

Chirurgie L2 — Traumatologie/Rhumatologie (définitions)

TRAUMATOLOGIE

La traumatologie est l'étude médicale des traumatismes physiques, c'est-à-dire des atteintes à la santé résultant d'une action extérieure violente et soudaine.

RHUMATOLOGIE

La rhumatologie est une spécialité médicale qui s'intéresse au diagnostic et au traitement des maladies de l'appareil locomoteur, c'est-à-dire des maladies des os, des articulations, des muscles, des tendons et des ligaments. Les rhumatologues (médecins spécialisés en rhumatologie) soignent également certaines affections neurologiques périphériques comme la sciatique et surtout l'ensemble des rhumatismes inflammatoires et maladies auto-immunes qui peuvent avoir de nombreuses manifestations extra-articulaires : peau, yeux, reins, poumons, etc.

SENSIBILITE PROPRIOCEPTIVE

Qui se rapporte à la sensibilité du système nerveux aux informations provenant des muscles, des articulations et des os. La sensibilité proprioceptive complète les sensibilités intéroceptive (qui concerne les viscères), extéroceptive (qui concerne la peau) et celle des organes des sens

La proprioception ou sensibilité profonde désigne la perception, consciente ou non, de la position des différentes parties du corps. Elle fonctionne grâce à de nombreux récepteurs musculaires et ligamentaires et aux voies et centres nerveux impliqués. La proprioception fait partie de la somesthésie

SOMESTHESIE

Somesthésie désigne l'ensemble des sensations qu'un être humain peut ressentir dans toutes les parties de son corps. Cela regroupe donc les sensations de pression, de chaleur, les douleurs, etc. La somesthésie est le principal système sensoriel

SIGNE DE LASEQUE

Le signe de Lasègue encore appelé EJT, élévation jambe tendue, est un signe clinique qui désigne une douleur apparaissant entre la zone lombaire et le pied lorsque le membre inférieur du patient allongé est relevé tendu

ESTHESIE

Aptitude à percevoir une sensation, sensibilité.

HEMATOME EXTRA-DURAL

L'hématome extradural (HED) ou épidural est une collection sanguine développée entre la dure-mère et l'os du crâne

INTERVALLE LIBRE

L'intervalle libre est un intervalle de temps après le traumatisme crânien où la conscience est normale

COMMOTION CEREBRALE

Une commotion cérébrale est une lésion cérébrale causée par un choc qui peut perturber le fonctionnement du cerveau. Les maux de tête, la difficulté à se concentrer, les pertes de mémoire, la sensibilité à la lumière et les problèmes d'équilibre ou de coordination sont au nombre des symptômes

Les symptômes immédiats ou tardifs sont notamment un état de confusion mentale, une vision trouble et une difficulté à se concentrer. Les nourrissons peuvent pleurer de façon incessante ou être irritables.

Le traitement peut comprendre du repos, la prise de médicaments et la chirurgie

SIGNE DE BABINSKI

Le signe de Babinski (ou réflexe cutané plantaire) est utilisé pour détecter une éventuelle lésion du système nerveux central

Le signe de Babinski : réponse en extension du gros orteil lors de la recherche du réflexe cutané plantaire (stimulation d'arrière en avant, du bord externe de la plante du pied). La réponse normale est une flexion du gros orteil. Parfois, un stimulus cutané quelconque peut déclencher un signe de Babinski.

QUESTIONS A CHOIX DIRECT (QCD)

Répondre par A = VRAI ou B = FAUX

Sachant que :

Bonne réponse =1 point,

Fausse réponse = -1 point

Absence de réponse = 0 point

L'appendicite est une inflammation de l'intestin grêle et du côlon Vrai/Faux

L'appendicite est l'inflammation brutale de l'appendice iléo-caecale Vrai/Faux

L'appendice est situé dans le flanc droit Vrai/Faux

L'appendicite est causée par une alimentation déséquilibrée Vrai/Faux

La voie hématogène est la modalité exceptionnelle de survenue de l'infection appendiculaire Vrai/Faux

La voie endogène est la modalité la plus habituelle de survenue de l'infection appendiculaire Vrai/Faux

Les nouveau-nés sont épargnés par l'appendicite Vrai/Faux

La gent féminine est épargnée par l'appendicite Vrai/Faux

L'appendicite atteint les adolescents plus que les adultes Vrai/Faux

Le traitement de l'appendicite est uniquement chirurgical Vrai/Faux

L'appendicite est la 1ère cause d'urgence en chirurgie digestive Vrai/Faux

Le diagnostic positif de l'appendicite est de raviver la douleur au point de Mac Burney Vrai/Faux

La manœuvre de Rosving consiste à décompresser brutalement la fosse iliaque gauche pour provoquer la douleur de l'appendicite Vrai/Faux

Le signe fonctionnel capital de l'appendicite est l'hyperthermie Vrai/Faux

L'appendicite touche plus les hommes que les femmes Vrai/Faux

Le signe capital fonctionnel de l'appendicite aigüe n'est pas la douleur abdominale constante, spontanée à la fosse iliaque droite Vrai/Faux

Le trouble du transit est constitué de constipation prédominant la diarrhée Vrai/Faux

L'appendicite touche plus les femmes que les hommes Vrai/Faux

Un débit trop rapide de perfusion peut créer un œdème aigu des poumons Vrai/Faux

La bronchite peut créer l'appendicite aigüe Vrai/Faux

Les appendicites ont des aspects variables en fonction de la gravité Vrai/Faux

L'appendicite atteint les adolescents plus que les adultes Vrai/Faux

L'appendicite est une maladie bénigne Vrai/Faux

L'appendicite est due à une mauvaise hygiène corporelle Vrai/Faux

L'appendicite peut être provoquée par une bronchite Vrai/Faux

Le signe du psoas est la flexion forcée de la cuisse droite qui entraîne la douleur Vrai/Faux

La manœuvre de BLUMBERG (positive) consiste à décompresser brutalement la FID pour provoquer la douleur Vrai/Faux

Par voie endogène ; l'appendicite réalise une obstruction de la lumière appendiculaire Vrai/Faux

La douleur provoquée lors de la palpation de la fosse iliaque droite pour le diagnostic de l'appendicite

est un signe fonctionnel ? Vrai/Faux

La défense pariétale lors de la palpation de la fosse iliaque droite pour le diagnostic de l'appendicite est un signe physique ? Vrai/Faux

L'adénome de la prostate est une tumeur maligne caractérisée par une hypertrophie et une hyperplasie de la glande prostatique A/B

L'adénome de la prostate est une tumeur bénigne caractérisée par une hypertrophie et une hyperplasie de la glande prostatique A/B

L'adénome de la prostate atteint aussi la femme A/B

L'adénome de la prostate est une affection qui touche les hommes de plus de 50 ans A/B

L'adénome de la prostate est caractérisé par des troubles urinaires A/B

L'adénome de la prostate est caractérisé par des troubles digestifs A/B

La prostate est un organe exclusivement masculin A/B

La prostate est située sous la vessie A/B

Après adénectomie, cette tumeur peut récidiver A/B

La principale complication de l'adénome de la prostate est le cancer A/B

L'abstinence est la meilleure prévention de l'adénome de la prostate A/B

La rétention urinaire aigüe se traduit par une impossibilité brutale et partielle d'uriner A/B

La rétention urinaire aigüe se traduit par une impossibilité brutale et totale d'uriner A/B

La rétention aigüe d'urines est dite complète A/B

La rétention urinaire chronique se traduit par l'impossibilité de vider totalement la vessie A/B

La rétention urinaire chronique est caractérisée par l'existence d'un résidu post-mictionnel A/B

Lorsque le résidu post-mictionnel est < 300cc, on parle de rétention sans distension A/B

Lorsque le résidu post-mictionnel est > 300cc, on parle de rétention avec distension A/B

La rétention aigüe d'urines se caractérise par l'absence de résidu post-mictionnel A/B

Lorsque le résidu post-mictionnel est très inférieur à 300cc, on parle de rétention urinaire aigüe A/B

La rétention incomplète d'urine crée un risque infectieux A/B

L'urètre est appelé aussi uretère A/B

L'urètre est un conduit unilatéral qui transporte les urines des reins vers la vessie A/B

L'uretère est un conduit bilatéral qui transporte les urines des testicules vers l'extérieur par le méat A/B

L'urètre est absent dans l'appareil génital féminin A/B

Le rétrécissement urétral est la réduction de la lumière de l'urètre A/B

Les brûlures par contact sont provoquées par le contact des tissus avec la source de chaleur A/B

La brûlure peut entraîner une déshydratation A/B

La brûlure peut entraîner une anurie A/B

Les brûlures par contact sont plus graves que celles provoquées par rayonnement A/B

Dypuytren a décrit selon la profondeur six degrés de brûlure A/B

L'occlusion est un arrêt temporaire du transit des matières et des gaz dans un segment intestinal A/B

L'occlusion est un arrêt complet et permanent du transit des matières et des gaz dans un segment intestinal A/B

L'occlusion est une obstruction totale ou partielle de l'intestin grêle ou du côlon A/B

Le but du traitement de l'occlusion est de lever ou supprimer l'obstacle A/B

Les occlusions inflammatoires sont aussi appelées mixtes A/B

Les occlusions mécaniques sont dues à un obstacle organique A/B

L'occlusion par strangulation se caractérise par l'existence de lésions vasculaires liées à l'écrasement ou à la torsion des vaisseaux du méso-colon A/B

Les occlusions fonctionnelles sont le fait du dérèglement du système nerveux intestinal A/B

Les occlusions hautes siègent sur l'œsophage A/B

La plaie est une solution de continuité de la peau A/B

Les plaies simples ne se limitent pas à l'effraction des tissus de revêtement A/B

Les plaies complexes sont appelées aussi plaies composées A/B

Les plaies complexes ou composées comportent outre la section cutanée une atteinte des tissus sous-jacents A/B

Les plaies situées sur les parties osseuses (coudes, genou, tibia, tête) évoluent vers l'ostéite A/B

Les escarres sont des plaies qui cicatrisent facilement A/B

Une plaie linéaire est due à un objet tranchant A/B

Une plaie contuse est due à un objet contondant A/B

Un micro-organisme pathogène peut créer une plaie A/B

Le diagnostic d'une plaie se fait simplement par l'inspection A/B

Les plaies par arme à feu sont moins graves que celles par arme blanche A/B

Le liquide qui suinte d'une plaie est l'exsudat A/B

L'alimentation n'a aucune importance concernant la cicatrisation d'une plaie A/B

La contusion abdominale est toute lésion produite par un agent extérieur au niveau de l'abdomen A/B

La contusion abdominale est un traumatisme de l'abdomen sans solution de continuité au niveau de la paroi abdominale A/B

La contusion abdominale est un traumatisme ouvert de la paroi abdominale A/B

La contusion abdominale est fréquente chez le jeune que chez l'adulte A/B

La contusion est un traumatisme fermé sans effraction du tissu de revêtement A/B

L'agent causal de la contusion est un agent contondant physique A/B

L'intestin grêle superficiellement exposé est une cause anatomique prédisposante de la contusion abdominale A/B

La rate paludéenne est une cause anatomique prédisposante de la contusion abdominale A/B

Les relâchements de la paroi abdominale sont une cause anatomique prédisposante de la contusion A/B

Les réplétions des intestins sont une cause anatomique prédisposante de la contusion A/B

La hernie est l'extériorisation spontanée, temporaire ou permanente d'un viscère à travers un point de faiblesse de l'abdomen A/B

La femme est exemptée de hernie A/B

La hernie est plus fréquente chez l'homme que la femme A/B

La hernie atteint exclusivement les hommes A/B

La hernie est seulement acquise A/B

La hernie est uniquement congénitale A/B

La hernie peut être congénitale ou acquise A/B

La hernie est l'issue spontanée d'un viscère hors des limites de la cavité abdomino-pelvienne A/B

S'agissant de l'abdomen, la hernie siège uniquement au niveau des zones de faiblesse de la paroi abdominale par un orifice préexistant A/B

L'étranglement herniaire est la constriction brutale serrée et permanente d'un viscère à l'intérieur du sac herniaire A/B

Le chemin qu'emprunte le viscère s'appelle le collet herniaire A/B

L'enveloppe de la hernie s'appelle le sac herniaire A/B

L'omphalocèle est la hernie ombilicale du nouveau-né A/B

Les hernies ombilicales s'observent le plus souvent chez les vieillards A/B

Le péritoine est la membrane qui enveloppe les viscères A/B

La péritonite est une inflammation brutale de la séreuse péritonéale A/B

Le péritoine permet de maintenir les organes au sein de la cavité abdominale A/B

La rate fait partie des organes digestifs A/B

La péritonite est toujours généralisée A/B

La péritonite peut atteindre une partie du péritoine A/B

On peut observer une péritonite dans toutes les régions de l'abdomen A/B

Le signe pathognomonique de la péritonite est la contracture abdominale A/B

Le « Ventre de bois » est la contracture permanente et invincible des muscles de la paroi abdominale A/B

La radiographie de l'abdomen sans préparation est l'examen le plus prescrit A/B

On appelle fracture, la solution de continuité d'un os A/B

On appelle fracture, la rupture de la continuité d'un os A/B

La fracture pathologique survient à la suite d'un traumatisme minime A/B

La fracture à étage est une fracture où le trait est double et délimite un 3ème fragment parallèle entre eux A/B

La fracture comminutive est une fracture où l'os s'est fracturé en plusieurs endroits A/B

La fracture incomplète avec flexion se rencontre chez l'enfant A/B

La fracture incomplète est encore appelée fracture « en bois vert » A/B

La radiographie est le seul examen permettant de confirmer la fracture A/B

On parle de fracture fermée lorsque le foyer de fracture ne communique pas avec l'extérieur par une plaie A/B

Il existe une solution de continuité de la peau dans une fracture fermée A/B

La fracture ouverte est une fracture dont le foyer de fracture communique avec l'extérieur par une plaie même minime des parties molles A/B

Dans la fracture ouverte, la peau reste intacte A/B

L'ostéosynthèse est appelée aussi traitement sanglant A/B

La réduction consiste à remettre les fragments osseux dans leur rapport anatomique A/B

L'ostéosynthèse consiste à un assemblage des fragments osseux d'une fracture à l'aide de matériel métallique A/B

L'ostéosynthèse : c'est l'ouverture chirurgicale du foyer de fracture A/B

La réduction d'une fracture se fait sous contrôle radiologique A/B

La contention d'une fracture se fait à l'aide d'un appareil plâtré A/B

La contention d'une fracture consiste à maintenir les fragments osseux dans leurs rapports normaux jusqu'à consolidation A/B

L'alimentation a une importance dans la consolidation d'un os fracturé A/B

L'hydrocèle est un épanchement liquidien séreux entre les deux feuillets de la vaginale A/B

L'hydrocèle est plus fréquente chez le nouveau-né A/B

L'hydrocèle n'atteint pas le sexe féminin A/B

La vaginale est une membrane qui entoure le testicule A/B

Excepté le bacille de Koch, tous les germes pathogènes peuvent créer une hydrocèle A/B

La parasitose crée une hydrocèle A/B

L'hydrocèle a les mêmes manifestations cliniques que la hernie étranglée A/B

L'hydrocèle est d'apparition insidieuse et d'évolution rapide A/B

L'un des buts de la conduite thérapeutique en cas de traumatisme du thorax est d'éviter les complications A B

Dans les signes de souffrance respiratoire, le sujet présente une lésion du nerf récurrent (trouble phonique) A B (voir document de L)2

La luxation incomplète est une subluxation. A B

Les lésions vasculo-nerveuses sont secondaires et générales des fractures du fémur A B

La luxation de l'épaule est un déplacement permanent plus ou moins important des deux surfaces articulaires, l'une par rapport à l'autre. A B

Le thorax est constitué d'un contenant fait de la cage thoracique grossièrement cylindrique et fermé en bas par les muscles diaphragmatiques et en haut par la base du cou. A B

En cas de traumatisme du thorax, l'inspection apprécie les vibrations vocales et le choc de pointe à l'étape analytique. A B

L'état de dépendance du patient fait partie du rôle de l'infirmier en préopératoire dans les traumatismes des ménisques. A B

L'impotence fonctionnelle relative ou absolue est un signe fonctionnel du traumatisme du bassin. A B

L'état de choc est un syndrome général de plus ou moins grande gravité, observé après toute agression de l'organisme quelle que soit sa nature. A B

Le polytraumatisé est tout malade ayant au moins deux traumatismes. A B

La soudaine inefficacité de la pompe cardiaque qui entraîne une chute brutale du débit cardiaque définit le choc cardiogénique A B

La précipitation est un geste salvateur dans la CAT auprès d'un traumatisé des voies publiques. A B

L'existence de lésions de l'abdomen est un élément de l'examen du traumatisé conscient des voies publiques. A B

Le thorax est constitué d'un contenant fait de quelques organes de passages, de l'appareil respiratoire, de l'appareil cardiovasculaire. A B

Le sujet présente une lésion du nerf récurrent (trouble phonique), dans les signes de souffrance respiratoire. A B

La subluxation est considérée comme une luxation incomplète. A B

L'une des étiologies du traumatisme du thorax est l'accident de sport. A B

La luxation de l'épaule est un déplacement permanent plus ou moins important de deux surfaces articulaires, l'une par rapport à l'autre. A B

Les lésions vasculo-nerveuses sont secondaires et générales des fractures du fémur.

A B

165) Éviter les complications fait partie des buts de la conduite thérapeutique en cas de traumatisme du thorax. A B

En cas de traumatisme du thorax, l'inspection apprécie aussi la déformation du thorax dans l'étape analytique. A B

En cas de fracture isolée ou étagée de côte à l'étape synthétique chez le traumatisé du thorax, on note une douleur à l'inspiration profonde. A B

Le mal de pott est une infection disco-vertébrale due au staphylocoque doré. A B

Le polytraumatisé est tout malade ayant au moins deux traumatismes. A A B (pour A= vrai compléter avec mettant en jeu le pronostic vital)

La ceinture scapulaire est un élément du squelette appendiculaire. A B

La traumatologie est la science qui étudie seulement l'atteinte ou les accidents du squelette axial et appendiculaire. A B

L'agent causal dans les contusions est un agent métaphysique. A B

48 h à 72 h suffisent pour libérer le patient, en cas de lésions internes graves au cours des contusions abdominales. A B

Les fractures de l'enfant sont dites fractures en « bois vert ».A B

Le choc direct fait partie des étiologies des fractures de l'humérus. A B

L'atteinte du nerf sciatique et l'hématome sont deux complications immédiates des fractures du fémur. A B

Les 02 complications tardives des fractures du fémur constituent l'amyotrophie du quadriceps et la raideur du genou. A B

La sciatalgie s'appelle aussi la névralgie sciatique A B

La sciatalgie est encore appelée sciatique A B

La sciatalgie est une maladie A B

La sciatalgie est un symptôme A B

La sciatalgie ou névralgie sciatique ou encore sciatique se définit comme toute douleur dans le territoire du nerf sciatique (L5 S1).A B

La commotion cérébrale est un épanchement sanguin intracrânien. A B

Dans les étiologies des traumatismes crâniens, plus de la moitié sont dues aux AVP A B

La notion d'intervalle libre est déterminée par la cotation de Glasgow. A B

Dans la cotation de score des Glasgow en cas de traumatisme crânien, le mouvement de retrait d'un membre est un élément de l'ouverture des yeux. B

Les traumatismes crânio-encéphaliques sont des causes des AVC. A B

Un déplacement monobloc est un déplacement qui maintient l'axe cranio-rachidien en rectitude A B

La douleur de la fracture du rachis est ressentie grâce à la sensibilité proprioceptive A. B

La tétraplégie et la paraplégie intéressent uniquement les membres inférieurs. A B

Le traumatisme du rachis peut entraîner une atteinte du sphincter vésical et anal A. B

La découverte d'une cyphose lombaire lors de l'examen physique d'un patient traumatisé du rachis présage une lésion ostéo-articulaire. A B

Le signe de Lasègue est recherché au décours d'une fracture du rachis .A B

Les lésions traumatiques du rachis peuvent entraîner une anesthésie, une esthésie et une hypoesthésie A B

Le mal de pott est une complication des sciatalgies A B

Le décubitus latéral fait partie des positions déconseillées dans l'installation d'un traumatisé du rachis. A B

Pour l'infirmier, la réfection de lit occupé et les soins de siège font partie des exigences pour un patient en immobilisation prolongée. A B

Une sonde urinaire à double courant est une sonde à trois voies. A B

Dans le traumatisme intracrânien, un intervalle libre d'une courte durée suspecte un hématome extradural. A B

Lors d'une hospitalisation prolongée, seule l'antibiothérapie permet de prévenir les complications

infectieuses. A B

Le rythme de changement d'une sonde à demeure est tout au plus deux fois par semaine. A B

La prévention des escarres est l'une des sept (7) recommandations dans la conduite des soins post-opératoires d'un traumatisé du rachis avec atteinte de l'axe neural. A B

Le rachis cervical et le rachis lombaire totalisent 12 vertèbres. A B

Un scalp pédiculé suturé nécessite ultérieurement une greffe cutanée A B

Le signe pathognomonique de la sciatique est la douleur lombo-sacrée A B

Les soins du siège et la réfection de lit préviennent les escarres. A B

Le rachis dorsal et le sacrum totalisent 19 vertèbres. A B

« L'intervalle libre » dans les traumatismes intracrâniens est le seul signe de l'hématome extradural. A B

Les fractures du rachis sont des lésions qui appartiennent aux lésions du squelette appendiculaire. A B

« L'intervalle libre » à la même durée en cas d'hématome extradural et d'hématome intradural dans les traumatismes crâniens. A B

Les fractures de la voûte crânienne peuvent irradier vers la base du crâne A B

Les fractures de la base sont considérées comme ouvertes A B.

Le diagnostic d'hématome extradural est formel lorsque l'intervalle libre est court A B

L'hématome extradural est une urgence parce qu'il réalise une compression cérébrale aigue A B

L'examen clinique d'un traumatisé du rachis doit comprendre de la recherche d'un syndrome lésionnel et sous lésionnel. A B

Plusieurs structures anatomiques peuvent être lésées lors d'un traumatisme crânien. A B

La commotion cérébrale est une altération simple fonctionnelle avec lésion matérielle du tissu cérébral A B

« L'intervalle libre » est la période pendant laquelle le traumatisé du crâne se plaint de douleur de la tête dans les suites immédiates de l'accident. A B

La traumatologie est la partie de la chirurgie qui étudie la pathologie des os A B

Le polytraumatisé est tout malade ayant aux moins deux traumatismes. A B

Dans la prise en charge d'un patient, l'examen clinique et les examens complémentaires ont des similitudes A B

La neurochirurgie est la science qui étudie seulement les fractures du crâne. A B

L'amnésie constitue un signe fonctionnel en cas de traumatisme crânien. A B

Dans les sciatalgies, les douleurs résultent d'une action physique et clinique. A B

Les kystes méningés sont une des causes des sciatalgies. A B

La somme des vertèbres du rachis dorsal ou thoracique et celles du rachis coccygien est égale à 19 A B

La commotion cérébrale est un épanchement sanguin intracrânien. A B

Dans les étiologies des traumatismes crâniens, plus de la moitié sont dues aux AVP A B

Dans la cotation de score des Glasgow en cas de traumatisme crânien, la flexion anormale des membres est un élément de l'ouverture des yeux. A B

Les AVC sont des causes des traumatismes crânio-encéphaliques A B

Un déplacement monobloc est un déplacement qui maintient l'axe cranio-rachidien en position déclive A B

La douleur de la fracture de la fibula est ressentie grâce à la sensibilité proprioceptive A. B

La paraplégie est une paralysie des membres inférieurs. A B

Le traumatisme du rachis peut entraîner uniquement une atteinte du sphincter vésical A B

La découverte d'une cyphose lombaire lors de l'examen physique d'un patient traumatisé du rachis présage une lésion de la ceinture pubienne A B

Le signe de Lasègue est recherché au décours d'un traumatisme thoracique A B

Les lésions traumatiques du rachis peuvent entraîner seulement une anesthésie, une esthésie et une hypoesthésie A B

Le mal de pott est une complication de la fracture du bassin A B

Le décubitus ventral fait partie des positions conseillées dans l'installation d'un traumatisé du rachis. A B

Pour l'infirmier, les soins de siège et la mobilisation passive des membres font partie des exigences pour un patient en immobilisation prolongée. A B

Dans les soins d'irrigation vésicale, le décaillotage se fait sur le trajet de la poche urinaire dans la sonde à trois voies. A B

Dans le traumatisme intracrânien, un intervalle libre d'une courte durée suspecte un hématome péri-dural. A B

Lors d'une hospitalisation post traumatique prolongée, l'antibiothérapie participe à prévenir les complications infectieuses. A B

Le rythme de changement d'une sonde à demeure est d'au moins deux fois par semaine. A B

La prévention des escarres est l'une des recommandations dans la conduite des soins du traumatisé de la clavicule. A B

Le rachis cervical et le rachis dorsal totalisent 15 vertèbres. A B

Un scalp non pédiculé nécessite ultérieurement une greffe cutanée A B

Le signe pathognomonique de la sciatique est la douleur cervicale A B

La réfection de lit prévient la survenue des escarres. A B

Le rachis cervical et le sacrum totalisent 19 vertèbres. A B

« L'intervalle libre » dans les traumatismes intracrâniens est le signe de l'hématome intracérébral. A B

Les fractures du rachis sont des lésions qui appartiennent aux lésions du squelette appendiculaire et axial. A B

« L'intervalle libre » à la même durée en cas d'hématome extradural et hématome intracérébral dans les traumatismes crâniens. A B

L'embarrure est une fracture de la voûte crânienne A B

Les fractures de la base du crâne sont des fractures fermées A B.

Chez les traumatisés du crâne, on traite l'œdème cérébral par les corticoïdes et les solutés isotoniques. A B

L'examen clinique d'un traumatisé du rachis doit comprendre la recherche d'un syndrome lésionnel uniquement A B

Seule les méninges peuvent être objets de lésions lors d'un traumatisme crânien. A B

« L'intervalle libre » est la période pendant laquelle le traumatisé du crâne se trouve en état d'ébriété dans les suites immédiates de l'accident. A B

La traumatologie est la partie de la chirurgie qui étudie la pathologie des articulations A B

Le polyfracturé est tout malade ayant aux moins deux traumatismes. A B

Dans la prise en charge d'un patient, l'examen clinique et les examens complémentaires ont des similitudes A B

La neurochirurgie est la science qui étudie les fractures du crâne et les lésions de la ceinture scapulaire A B

L'amnésie constitue un signe physique en cas de traumatisme crânien. A B

Dans les sciatalgies, les douleurs résultent d'une action physique uniquement. A B

Les kystes méningés sont la principale cause des sciatalgies. A B

La somme des vertèbres du rachis dorsal ou thoracique et celles du rachis coccygien est égale à 20 A B

Au cours d'un traumatisme crânien, plusieurs structures anatomiques sont sensibles d'être lésées. A B

La mydriase est la dilation du diamètre de la pupille. A B

L'arachnoïde fait partie des 3 enveloppes qui recouvrent le parenchyme cérébral. A B

L'amnésie constitue un signe physique en cas de traumatisme crânien. A B

Dans les sciatalgies les douleurs résultent d'une action physique ou chimique. A B

Les kystes méningés sont des complications des sciatalgies. A B

Le thorax est constitué d'un contenu fait de quelques organes de passages, de l'appareil respiratoire, de l'appareil cardiovasculaire. A B

La luxation est une subluxation considérée comme incomplète. A B

Les accidents au jeu de rugby sont l'une des étiologies du traumatisme du thorax est. A B

La luxation de l'épaule est un déplacement partiel plus ou moins important de deux surfaces articulaires, l'une par rapport à l'autre. A B

Éviter les complications fait partie des buts de la conduite thérapeutique en cas de traumatisme du thorax. A B

En cas de traumatisme du thorax, l'inspection peut apprécier aussi l'existence d'un volet costal dans l'étape analytique. A B

Une respiration paradoxale peut être observée en cas de fracture étagée de côte à l'étape synthétique chez le traumatisé du thorax A B

Le mal de pott est une infection disco-vertébrale due au gonocoque. A B

Le polytraumatisé est tout malade ayant au moins deux traumatismes dont l'un met en jeu le pronostic vital. A B

La ceinture scapulaire est un élément du squelette axial. A B

Les causes des contusions abdominales sont uniquement physiques. A B

24 heures suffisent pour libérer le patient, en cas de lésions internes graves au cours des contusions abdominales. A B

Les fractures de l'enfant sont dites des fractures étagées. A B

Le choc direct fait partie des étiologies des fractures de l'humérus. A B

Les 02 complications tardives des fractures du fémur constituent l'amyotrophie du quadriceps et le syndrome de Wolkman A B.

La sciatalgie s'appelle aussi l'amyotrophie A B

La sciatalgie est une maladie et un symptôme A B

La sciatalgie ou névralgie sciatique ou encore sciatique se définit comme toute douleur dans le territoire du nerf sciatique (D10 et S1). A B

Le panaris siège aussi sur un orteil A B

La fièvre est un diagnostic A B

Le panaris est toute infection aiguë d'un doigt A B

Le porteur sain est une personne apparemment malade qui sème les germes autour de lui. A B

L'automédication peut créer la résistance aux germes A B

Il y a absence de fièvre dans la clinique d'un furoncle A B

II) QUESTIONS A CHOIX MULTIPLE (Q.C.M.)

Répondre aux items suivants sachant que :

Bonne réponse = 1 point,

Fausse ou absence de réponse = 0 point

La rate est située dans : choisir la bonne réponse

L'hypochondre gauche

L'hypochondre droit

Le flanc gauche

Le flanc droit

La fosse iliaque gauche

La fosse iliaque droite

Les signes de l'inflammation de l'appendice sont : choisir 4 éléments

Tuméfaction

Douleur

Fièvre

Rougeur

Rogeur

Prostration

L'infection appendiculaire peut survenir selon deux modalités : lesquelles ?

La voie endogène

La voie hématogène

La voie lymphatique

Les signes fonctionnels de l'appendicite aiguë sont : choisir 4 réponses

Douleurs abdominales constantes

Nausées et vomissements

Troubles du transit

Céphalées

Fièvre

Arthralgies

Les signes physiques de l'appendicite aiguë sont :

Augmentation du volume abdominal

une position antalgique fréquente, cuisse droite fléchie

Météorisme abdominal

Dépigmentation cutanée localisée dans la fosse iliaque droite

Diminution de la respiration au niveau de la fosse iliaque droite

Augmentation de la fréquence respiratoire

A la palpation deux signes fondamentaux sont à rechercher dans la fosse iliaque droite. Lesquels ?

Douleur provoquée

Défense pariétale

Chaleur localisée

Concrétion dure formée à partir des matières fécales

Les causes de l'appendicite aiguë sont : choisir toutes les bonnes réponses

Infections

Calcul appendiculaire

Parasitoses intestinales

Corps étrangers

Coprolithe (stercolithe – fécalite)

Toutes ces réponses

La manœuvre de BLUMBERG (positive) consiste à : choisir la bonne réponse

décompresser brutalement la FID pour provoquer la douleur

B- presser la FID pour provoquer la douleur dans la FIG

C- mieux exposer la région inguinale à la défense de la FID

à la palpation

Le signe du psoas: choisir la bonne réponse

la flexion forcée de la cuisse droite est douloureuse

la flexion forcée du membre supérieur droit est douloureuse

l'extension du membre supérieur droit est douloureuse

l'extension du membre inférieur droit est douloureuse

La liste ci-dessous contient 3 examens biologiques à faire pour confirmer l'appendicite, lesquels?

N.F.S Hyperleucocytose sup 10.000 élt/mm³ à PNN

Elévation de CRP

Accélération de VS

GE/FS

Sérodiagnostic de Widal et Félix

Test d'Elisa

Quels sont les 3 examens radiologiques à faire pour confirmer le diagnostic ?

Radiographie abdomen sans préparation

Radiologie abdomen avec préparation

Echographie abdominale

Tomodensitométrie abdominale

Electrocardiogramme

Coelioscopie

Quels sont les éléments du diagnostic différentiel de l'appendicite et des affections médicales ?
(Trois réponses)

torsion de kyste de l'ovaire chez la femme

typhoïde

hépatite B

gastro-entérite

péritonite primitive

arthrite de la hanche

Les complications de l'appendicite aiguë sont : choisir toutes les bonnes réponses

Plastron appendiculaire (masse palpable dans la FID)

Abcès appendiculaire (collection de pus)

Perforation de l'appendice

Péritonite localisée ou généralisée

Septicémie

L'ensemble de ces réponses

Quels sont les buts de traitement de l'appendicite ? (2 réponses)

Supprimer le foyer infectieux

Eviter l'évolution vers les complications

Calmer la douleur

Administrar la médication

Dissiper l'anxiété du patient

Les objectifs de soins pour un patient qui doit subir une appendicectomie sont : (1 réponse)

Réduire l'anxiété

Assurer l'exécution des examens préopératoires

Conseiller le jeûne au moins 72 heures avant l'intervention

Les rôles de l'IDE au CSR dès l'appendicite suspectée sont :(1seule réponse)

Appeler le médecin pour confirmer le diagnostic

Demander au patient de réaliser les examens

Référer le patient dans un centre plus équipé

Les rôles de l'IDE à l'hôpital sont : (4 réponses)

Contrôler les constantes hémodynamiques

Vérifier la réalisation du bilan paraclinique

Réaliser le groupe/rhésus

Favoriser l'hospitalisation du patient

Réaliser l'appendicectomie

Surveiller le pansement

Les interventions infirmières préopératoires dans l'appendicectomie sont :

Prescrire des solutés au patient

Administrar la prémédication la veille de l'intervention

Informer le patient sur la nature des actes de la pathologie

Maintenir à jeun le patient au moins 72 heures avant l'intervention

Aseptiser la région de l'intervention

Vérifier la réalisation des différents examens d'opération

Quels sont les rôles de l'IDE en peropératoire ?

Préparer psychologiquement le patient à l'intervention

Apprêter les appareils dans la chambre du patient

Contrôler le réveil du patient

Dresser le lit du patient pour attendre son retour

Etre l'intermédiaire entre le bloc opératoire et la famille

Dissiper les informations erronées des membres de la famille

Quelles sont les fonctions de la prostate parmi celles qui sont énumérées en dessous ?

participe à la constitution du sperme

participe au bon fonctionnement de l'éjaculation

corrige la faiblesse sexuelle

améliore la performance sexuelle

allonge l'organe sexuel

sécrète des hormones

quelles sont les complications de l'adénome de la prostate parmi celles-ci ?

rétention urinaire

insuffisance cardiaque

insuffisance hépatique

insuffisance rénale

Quels sont les signes fonctionnels de l'adénome de la prostate parmi ceux-ci ?

dysurie

Pollakiurie nocturne et/ou diurne

Impériosité mictionnelle

Miction retardée

Diminution de la force et du calibre du jet

Gouttes retardataires

Miction en plusieurs temps ou incontinence urinaire

Allongement de la durée de l'évacuation

Toutes ces réponses sont vraies

Quels sont les signes physiques de l'adénome de la prostate parmi ceux-ci ?

Toucher rectal (vessie vide) pour apprécier le volume de la prostate

Palpation des deux fosses lombaires pour rechercher un gros rein (hydronéphrose ou tumeur)

Percussion pour rechercher un globe vésical par matité

Pollakiurie diurne et/ou nocturne

Jet urinaire haché et/ou faible

Impression de vidange vésicale incomplète

Quels sont les examens biologiques à faire pour poser le diagnostic de l'adénome de la prostate ?

ASP

Créatinine pour apprécier le fonctionnement

ECBU à la recherche d'une infection éventuelle

PSA pour apprécier le degré d'évolution

IRM

TDM

Quels sont les examens radiologiques à faire pour poser le diagnostic ?

Échographie rénale, vésicale et prostatique pour surveiller la rétention sur le haut appareil urinaire

Urographie intraveineuse(UIV) ou cystoscopie pour évaluer les répercussions

La radiographie de l'abdomen sans préparation

Le lavement baryté

Quelles sont les actions infirmières avant l'intervention ?

Demander le bilan préopératoire

Faire des soins de propreté corporelle au patient

Préparation psychologique sur l'intervention

Préparation du champ d'intervention la veille

Faire observer le jeûne

Faire la prémédication

Quelles sont les actions infirmières avant le retour du patient du bloc opératoire ?

Prévoir une feuille de surveillance

Réfection du lit

Apprêter les potences et appareils

Prise des constantes hémodynamiques

Surveiller le réveil physiologique du patient

Quelles sont les interventions infirmières au retour du patient du bloc opératoire ?

Surveillance des signes vitaux et de la conscience

Vérification de la perméabilité des perfusions et leur débit

Surveillance du pansement

Surveillance du faciès, des conjonctives

Recherche des signes de caillotages: douleurs vésicales, coloration des urines, arrêt de l'écoulement de la sonde

Administration du traitement

Conseils pour le suivi post-opératoire et le respect des rendez-vous

Toutes ces réponses sont justes

Identifiez les signes fonctionnels de la rétention aiguë parmi ceux qui sont énumérés en dessous ?

Fièvre

Impossibilité d'uriner

Douleur sus-pubienne

Besoins impérieux d'uriner

Masse hypogastrique

Douleur à la palpation

Quels sont les signes physiques de la rétention urinaire aiguë parmi ceux-ci ?

Fièvre

Impossibilité d'uriner

Douleur sus-pubienne

Besoins impérieux d'uriner

Masse hypogastrique

Douleur à la palpation

Quels sont les signes fonctionnels de la rétention urinaire chronique parmi ceux qui sont énumérés ci-dessous ?

Pollakiurie diurne ou nocturne

Incontinence par regorgement

Présence de globe vésical flaccide

Indolore à la palpation

Parfois gros reins distendus

Fièvre

Parmi les signes cliniques énumérés ci-dessus ; lesquels sont des signes physiques ?

A-• ollakiurie diurne ou nocturne

B-"æ6öçF-æVæ6R " &Vv÷&vVÖVç@

C-• .—6Væ6R FR vÆö&R `ésical flaccide

D-"-æFöÆ÷&R Æ Ç F-öà

E-• arfois gros reins distendus

F-Fièvre

Quelles sont les étiologies des rétentions urinaires parmi celles qui sont énumérées en dessous ?

Adénome de la prostate

Rétrécissement urétral scléro-inflammatoire

Phimosis serré

Maladie du col vésical

Rétroversion de l'utérus gravidique

Activité sexuelle intense

Quelles sont les étiologies d'un rétrécissement urétral ?

La gonococcie

Le bacille de Koch

La bilharziose

Le traumatisme iatrogène ou accidentel

Le rapport sexuel

La consommation des excitants

Parmi les signes cliniques énumérés ci-dessous ; lesquels sont des signes fonctionnels de rétrécissement urétral ?

Dysurie avec jet urinaire très fin

Miction prolongée par des gouttes retardatrices

Douleurs lombaires avec masses à la palpation

Distension vésicale

Incontinence ou miction par regorgement

Pollakiurie consécutive à l'apparition d'un résidu vésical

Parmi les signes cliniques énumérés ci-dessous ; lesquels sont des signes physiques du rétrécissement urétral ?

Dysurie

Miction prolongée par des gouttes retardatrices

Douleurs lombaires avec masses à la palpation

Distension vésicale

Incontinence ou miction par regorgement

Pollakiurie consécutive à l'apparition d'un résidu vésical

Quels sont les examens radiologiques à réaliser pour confirmer le rétrécissement urétral parmi ceux-ci ?

L'urétrocystographie : permet de visualiser l'urètre et la vessie

L'urétrographie intraveineuse : permet de visualiser les reins, la vessie, les uretères, l'urètre

L'urétrocystographie rétrograde : permet d'identifier des anomalies de l'urètre (cicatrices, déchirures ...)

Le dosage de la PSA

L'ASP

L'Echographie abdominale

Quelles sont les deux méthodes de traitement du rétrécissement urétral ?

La méthode instrumentale : dilater l'urètre avec des bougies de Beniqué sous anesthésie

La méthode chirurgicale à pratiquer l'urétrotomie : inciser l'urètre

La méthode chirurgicale à pratiquer l'urétroplastie : réparer les pertes de substances

La laparotomie : ouverture de l'abdomen

La coelioscopie : observer l'intérieur de l'abdomen

La poche d'une sonde à demeure se vide, lorsque celle-ci est :

a. $\frac{1}{2}$ remplie

b. pleine

c. remplie aux $\frac{3}{4}$

L'intestin grêle long d'environ 7 m se divise en trois parties. Lesquelles ?

Le duodénum

Le jéjunum

L'iléon

L'appendice

Le caecum

Le côlon se divise en trois parties. Lesquelles ?

Le côlon ascendant

Le côlon transverse

Le côlon descendant

Le sphincter anal

L'anus

L'OIA relève de trois (03) processus qui sont :

Les occlusions chimiques

Les occlusions mécaniques

Les occlusions fonctionnelles

Les occlusions inflammatoires (ou mixtes)

Les occlusions thermiques

Les occlusions hormonales

Le syndrome occlusif est constitué de : choisir la bonne réponse

Signes cliniques uniquement

Signes biologiques uniquement

Signes radiologiques uniquement

L'ensemble des signes clinique, biologique et radiologique

L'obstacle organique dans les occlusions mécaniques relève de deux mécanismes. Lesquels ?

L'obturation

La strangulation

L'étirement

Le déchirement

L'éclatement

La dispersion

Dans l'OIA mécanique l'obturation ou l'obstacle peut intéresser ;

La lumière intestinale

La paroi intestinale

La compression du tube intestinal

Toutes ces trois réponses sont justes

La strangulation se caractérise par : (3 réponses)

Un volvulus

Une invagination

Une incarceration d'une anse dans un orifice ou une logette

Une élongation de l'anse

Un raccourcissement de l'intestin

Les occlusions fonctionnelles se manifestent soit par :

une paralysie des anses

des spasmes

les 2 réponses sont justes

les occlusions mixtes se rencontrent au cours :

des péritonites aiguës

des péritonites chroniques

d'affections septiques de voisinage

toutes les réponses sont justes

les quatre (04) symptômes essentiels qui caractérisent l'occlusion sont : choisir la bonne réponse

1 signe fonctionnel et 3 signes physiques

3 signes fonctionnels et 1 signe physique

2 signes fonctionnels et 2 signes physiques

Les plaies seront réparties en :

Plaies simples

Plaies complexes

Les deux réponses sont justes

La plaie linéaire est due à :

Lame

Couteau

Machette

Fusil

poignard

Grenade

Quels sont les facteurs de gravité d'une plaie parmi ceux qui sont énumérés ci-dessous ?

La localisation

Les circonstances de survenue

La profondeur

La douleur

Le mécanisme

L'aspect

Quels sont les facteurs de gravité d'une plaie en rapport?

Plaie dont le siège est l'abdomen, proximité d'un orifice naturel

Plaie souillée avec présence ou non de corps étrangers

Plaie étendue et profonde

Plaie contuse à bords irréguliers ou déchiquetés

Plaie délabrée superficielle

Plaie linéaire non profonde

Quelles sont les plaies simples parmi celles-ci qui sont énumérées en dessous ?

Plaies linéaires non profondes

Délabrements cutanés superficiels

Ulcère phagédénique (qui ronge)

Ulcère variqueux (mauvaise circulation sanguine)

Larges délabrements pas profonds

Plaies situées sur les parties osseuses (coudes, genou, tibia, tête)

Identifiez les plaies complexes parmi celles énumérées en dessous ?

Plaies punctiformes superficielles

Délabrements cutanés superficiels

Ulcère de Buruli

Plaies linéaires profondes

Larges délabrements profonds

Les plaies situées sur des parties non charnues

Un délabrement cutané profond ou pas est dû à :

un barbelé en fer

une chaîne de vélo

une chaîne de moto

un coup de massue

un coup de poing

les plaies punctiformes profondes ou pas peuvent être dues à :

un objet pointu

une balle d'arme à feu

un poignard

un bâton

une machette

une lame

les complications des plaies sont :

surinfection

septicémie

gangrène

ulcère de Buruli

large délabrement profond

les mauvaises cicatrisations des plaies aboutissent à :

pseudarthrose

cals vicieux

chéloïdes

brides au niveau des plis

cicatrices rétractiles

Quelles sont les causes des contusions abdominales ? (3 réponses)

Accidents de la voie publique

Accident de travail et de sport

Agressions ou Rixes

Obésité

Emaciation

Dermatoses

Quelles sont les mécanismes de survenue des contusions abdominales ? (1 seule réponse)

Choc direct uniquement

Choc indirect uniquement

Choc direct et/ou indirect

Choc septique

Choc hypovolémique

Choc anaphylactique

Quels sont les agents contondants physiques pouvant être responsables de contusions abdominales : (2 réponses)

Le bâton

Le couteau

Le fusil

La manchette

Le marteau

Le choc indirect dû à la décélération brutale entraîne des lésions de : (3 réponses)

Etirement

Rupture

Arrachement des moyens de fixité des viscères intra abdominaux

Délabrement

Nécrose

Macération

Les contusions des parties molles peuvent réaliser 4 types de lésions : lesquelles ?

l'épanchement sanguin (provoqué par la rupture des vaisseaux sanguins)

l'épanchement séreux (provoqué par un choc tangentiel qui rompt les lymphatiques)

la nécrose primaire de la peau (provoquée par un acte chirurgical)

la nécrose secondaire de la peau (provoquée par un écrasement des capillaires après une contusion des extrémités ou de la jambe)

les décollements cutanés (ce sont des épanchements séro-hématiques qui décollent la peau et la graisse)

Il existe 3 causes prédisposantes des contusions. Lesquelles ?

Les causes anatomiques

Les causes physiologiques

Les causes pathologiques

Les causes biologiques

Les causes radiologiques

Parmi les causes prédisposantes des contusions abdominales énumérées ci-dessous, quelles sont celles qui relèvent des causes physiologiques ? (2 réponses)

le cas des intestins grêles superficiellement exposés

les relâchements de la paroi abdominale

les réplétions des intestins

les intestins adhérents

Parmi les causes prédisposantes des contusions abdominales énumérées ci-dessous, quelles sont celles qui relèvent des causes pathologiques ? (3 réponses)

le cas des intestins grêles superficiellement exposés

les relâchements de la paroi abdominale

les réplétions des intestins

Les intestins adhérents

E- Le foie

F-La rate paludéenne

Identifiez les organes qui sont entourés par le péritoine.

La langue

L'œsophage

L'estomac

L'intestin grêle

Le foie

La rate

La péritonite est secondaire à une agression :

Bactérienne

Chimique

blesure

Toutes les réponses sont justes

On distingue trois (3) types de péritonite :

Primitives

Secondaires

Tertiaires

Quaternaires

Quelles sont les trois (03) causes les plus fréquentes de la péritonite ?

Perforation appendiculaire

Perforation d'ulcère gastroduodénal

Perforation du grêle d'origine typhique

Salpingite

Pancréatite aiguë

Cholécystite aiguë

Quels les signes fonctionnels dans la péritonite aiguë généralisée ou diffuse ?

Douleur abdominale

Vomissements

Arrêt des matières et des gaz

Hoquet

Immobilité diaphragmatique à l'inspection

Contracture abdominale à la palpation

A l'auscultation, on a :

Silence abdominal

Bruits hydro aériques

Silence abdominal et gargouille

Quels les signes généraux dans la péritonite aiguë généralisée ou diffuse?

Fièvre

Langue saburrale

Signes de choc hypovolémique

Altération du faciès

Déshydratation

Toutes ces réponses sont justes

La péritonite évolue rapidement vers :

Choc hypovolémique

Choc septique

Choc cardiogénique

Toutes ces réponses sont justes

Quelles sont les causes pré disposantes de la péritonite chronique ?

L'obésité

L'activité sexuelle

La grossesse

L'accouchement

L'alcoolisme

L'inactivité physique

Enumérez les buts du traitement de la péritonite

Corriger les désordres hydro électrolytiques

Supprimer la source de contamination

Réduire la contamination bactérienne

Prévenir et traiter les complications

Toutes ces réponses sont justes

Le traitement médical de la péritonite comporte :

Aspiration gastrique

Correction des déséquilibres hydriques et électrolytiques

Antibiothérapie à large spectre

Transfusion sanguine uniquement

Voies veineuses

Sonde nasogastrique

Sonde urinaire à demeure

La fracture est due à:

Un choc direct

Un choc indirect

Les deux réponses sont justes

Le mécanisme de survenue du choc indirect est par :

Compression

Traction

Traction-compression

Il existe deux types de fractures. Lesquelles ?

La fracture incomplète ou partielle

La fracture complète

La fracture totale

Lors d'une fracture, on peut observer un déplacement de fragment osseux :

Transversal ou en baïonnette

Angulaire ou angulation

Longitudinal ou chevauchement

Rotatoire ou décalage

Tous ces déplacements peuvent être associés dans une même fracture

Quels sont les signes fonctionnels de la fracture parmi ceux-ci ?

douleur vive

impotence fonctionnelle absolue ou partielle.

déformation du membre

mobilité anormale du segment du membre

crépitation osseuse due à la mobilisation des fragments osseux l'un contre l'autre

Quels sont les signes physiques de la fracture parmi ceux-ci ?

douleur vive

impotence fonctionnelle absolue ou partielle.

déformation du membre

mobilité anormale du segment du membre

crépitation osseuse due à la mobilisation des fragments osseux l'un contre l'autre

Certains gestes sont à proscrire lors de l'examen clinique d'un blessé. Lesquels ?

La recherche de la mobilité

La crépitation osseuse

L'agent causal

Les circonstances de survenue

Les lésions associées

Il existe deux types de fractures. Lesquels ?

La fracture continue

La fracture prolongée

La fracture fermée

La fracture ouverte

Il existe deux méthodes de traitement pour la fracture. Lesquelles ?

Le traitement par irradiation

Le traitement par chimiothérapie

Le traitement par Imagerie par résonnance magnétique

Le traitement orthopédique

Le traitement sanglant ou ostéosynthèse

Deux risques majeurs sont à redouter en cas de fracture ouverte. Lesquels ?

La septicémie

La gangrène

L'amputation

L'infection

Le retard de consolidation

Le traitement de fracture vise deux buts. Lesquels ?

Le rétablissement anatomique de l'os

Le rétablissement de la fonction du membre atteint

La résection

L'amputation

Lesquelles sont des complications immédiates des fractures parmi celles qui sont énumérées en dessous ?

Etat de choc traumatique

Lésion cutanée

Lésions des parties molles

Lésions vasculaires

Lésions nerveuses

Déplacements secondaires locaux

Identifiez les complications secondaires d'une fracture parmi celles-ci.

A- Lésions nerveuses

B- Lésions vasculaires

C-Retard de consolidation

D-Pseudarthrose

Cal vicieux

Atrophie musculaire

Raideur articulaire ou ankylose

Déplacement secondaire local

Quelles sont les complications tardives parmi celles qui sont ci-dessous énumérées ?

- A- Lésions nerveuses
- B- Lésions vasculaires
- C-Retard de consolidation
- D-Pseudarthrose
- E-Cal vicieux
- F-Atrophie musculaire
- G-Raideur articulaire ou ankylose

Quelles sont les composantes du traitement orthopédique ?

- La réduction
- La contention
- La contemplation
- L'amputation
- L'éducation
- La rééducation

L'ostéosynthèse peut se faire avec des :

- Bandes
- Echarpes
- Cordes
- Fils de fer
- Clous
- Vis
- Plaques
- Agrafes

Le délai de consolidation d'une fracture de la clavicule est estimé à :

- 4 semaines
- 6 semaines
- 8 semaines

Le délai de consolidation d'une fracture de l'humérus est estimé à :

- 4 à 6 semaines
- 6 à 8 semaines
- 8 à 12 semaines
- 3 à 4 mois
- 4 à 6 mois
- 6 à 12 mois

Le délai de consolidation d'une fracture des 2 os de l'avant-bras est estimé à :

- A-"B b 6VÖ –æW0
- B-"b , 6VÖ –æW0
- C-" , " 6VÖ –æW0
- D-"2 B Öö—0
- E-"B b Öö—0

F-“b " Öö—0

Le délai de consolidation d'une fracture du fémur est estimé à :

A-“B b 6VÖ —æW0

B-“b , 6VÖ —æW0

C-“, " 6VÖ —æW0

D-“2 B Öö—0

E-“B b Öö—0

F-“b " Öö—0

Le délai de consolidation d'une fracture des 2 os de la jambe est estimé à :

A-“B b 6VÖ —æW0

B-“b , 6VÖ —æW0

C-“, " 6VÖ —æW0

D-“2 B Öö—0

E-“B b Öö—0

F-“b " Öö—0

La réduction se fait par :

Manipulation manuelle interne

Manipulation manuelle externe

Traction mécanique au moyen d'une orthopédique

Traction électrique

Les hommes âgés peuvent développer une hydrocèle suite à :

Une blessure

Une inflammation

Une activité sexuelle accrue

Quels sont les germes (au lieu de parasites : à supprimer) le plus souvent à l'origine d'une hydrocèle, parmi ceux-ci ?

La bilharziose

La filariose

Le B.K

Le VIH

Le covid-19

Le streptocoque

Le pneumocoque

Quelles sont les causes probables d'une hydrocèle parmi celles-ci ?

Inconnue

Acquise

Congénitale

Héréditaire

Alimentaire

L'hydrocèle peut être acquise suite à :

Une orchite aigüe

Un cancer de testicule

Une torsion de kyste testiculaire

Une cryptorchidie

Dans la liste ci-dessous deux définitions de l'asepsie sont admises, lesquelles ?

L'absence de tout germe bactérien pathogène

L'absence de tout germe bactérien susceptible de provoquer des infections

L'ensemble des méthodes qui ont pour but de détruire les microbes

L'ensemble des méthodes qui préserve contre la souillure des microbes

L'ensemble des méthodes qui préserve contre la souillure des bactéries

L'absence de tout élément susceptible de provoquer la putréfaction ou l'infection

La liste ci-dessous contient les différentes phases de l'inflammation au plan local; lesquelles?

Phase pyrogène

Phase cellulaire

Phase douloureuse

Phase vasculaire

Phase de réparation

Phase œdémateuse

S'agissant du patient, lorsque l'on parle de terrain en chirurgie, il s'agit

De l'état physiologique de l'infecté

Du lieu de travail du personnel soignant

De la porte d'entrée du germe en cause

De l'état physique (clinique) du patient

Deux des pathologies ci-dessous sont des maladies infectieuses en chirurgie

Septicémie à perfringens

Diarrhée parasitaire

Accès palustre

Panaris

Diabète

Toux

L'infirmier prélève le sang pour l'hémoculture en période de frissons chez le patient parce que

Le germe est dans la porte d'entrée

Le germe est plus gros

Le germe est dans le sang

Le germe se multiplie dans le sang

Les signes ci-dessous sont dits physiques dans la septicémie (trois réponses)

Hyper pyrexie

Cardiomégalie

Eruptions cutanées

Splénomégalie

Arthralgie

Oligurie

La septicémie à perfringens a pour porte d'entrée

Les infections urinaires

Une plaie mal traitée

La ponction veineuse

Un avortement provoqué

La septicémie peut avoir pour porte d'entrée (deux réponses)

La dépigmentation cutanée

Une barbe mal taillée

La ponction veineuse

Un foyer aseptique

Un foyer septique

Une embolie

La septicémie se définit comme étant

Une décharge de germes dans un organe

Une décharge de germes dans toutes les cellules

Une multiplication de germes dans un tissu

Une décharge répétée de germes dans le sang

Tous les éléments de la liste ci-dessous sont des portes d'entrée d'une septicémie sauf un, lequel ?

Otite,

Sinusite chronique,

Angine banale

Phlébite

Panaris

Selon les formes étiologiques, les amygdalites et les infections urinaires sont à la base de deux septicémies, lesquelles ?

La septicémie à streptocoque

La septicémie à staphylocoque doré

La septicémie à colibacille

La septicémie à pyocyanique

La septicémie à perfringens

Inciser un abcès collecté au point le plus déclive signifie

Le point le plus latéral

Le point le plus haut

Le point le plus bas

Le point le plus médian

L'apparition d'une septicémie est toujours

Progressive

Pernicieuse

Intermittente

Brutale

Les signes de la septicémie ci-dessous sont fonctionnels

Arthralgie

Hyperthermie

Faciès tiré

Oligurie

Pouls filant

Eruptions cutanées

La liste ci-dessous contient les localisations des formes septicopyoémies de la septicémie

La lymphangite

Les panaris

La spondylite

La pneumonie

La carie dentaire

La prise en charge étiologique d'un abcès froid dure

Au moins 24 semaines

Au moins 6 semaines

Au plus 24 semaines

Au plus 6 semaines

L'abcès froid est une infection causée par

Le bacille d'Eberth

Le bacille de Koch

Le bacille de Nicolaier

Le colibacille

Monsieur DZZ souffre d'un panaris. Le traitement général qu'il reçoit comporte

Une antibiothérapie adaptée

Un pansement à plat avec

Un bandage du membre en position de fonction

Une incision toilette

Une sérothérapie antitétanique

Un prélèvement biologique suivi d'antibiogramme

Le crochet digital semi fléchi est un signe physique de l'une des pathologies ci-dessous, laquelle ?

Le phlegmon

La lymphangite

L'abcès lymphatique

Le panaris péri-unguéal

Les parties du corps humain ci-dessous peuvent être le siège d'une lymphangite sauf deux, lesquelles ?

Les seins

Le talon

Le bras

La verge

La langue

Les paupières

Dans l'évolution des maladies infectieuses, une septicopyoémie est une complication

Régionale

Générale

Locorégionale

Locale

La liste ci-dessous contient les facteurs généraux favorisant les furoncles (deux éléments de réponse)

Dermatoses prurigineuses

Fièvres éruptives

Manque d'hygiène corporelle

Usage des antibiotiques

Agression chimique de la peau

Présence d'un diabète

La prise en charge du furoncle consiste à

Faire une antibiothérapie systématique

Presser le furoncle

Faire un antibiogramme

Rechercher systématiquement un diabète

Faire un pansement avec un antiseptique

Conduire le patient chez le cardiologue

La zone de prédilection de l'anthrax est

Le dos

L'aile du nez

La fesse

La nuque

La liste ci-dessous contient des porteurs sains, lesquels?

La blouse bien dressée de l'infirmier et celle de la sage-femme

Le fauteuil du Directeur de l'hôpital et le brassard du tensiomètre

Le pharmacien du CHR

L'informaticienne du CHU

Aucune des réponses proposées

Les assertions suivantes relatives à l'abcès froid ci-dessous sont justes

L'abcès froid est un abcès chaud refroidi

L'abcès froid a pour foyer septique le phlegmon

Le drainage de l'abcès froid se fait au point déclive

La prise en charge thérapeutique dure 6 mois au moins

Le mal de POTT est un foyer septique de l'abcès froid

Le prélèvement de sang se fait au moment des frissons

Le rôle de l'infirmier dans le traitement des panaris consiste à

Surveiller la régression des signes

Faire le pansement

Faire la rééducation après cicatrisation

Faire la radiographie de la lésion

Faire la contention avec des broches

Surveiller la qualité du sommeil du patient

En tant qu'infirmier, vous stérilisez le matériel suivant au poupinel

Lames de bistouri

Toile cirée

Pince à disséquer

Gants propres

Sondes urinaires

Plateau inox

L'abcès chaud se caractérise au stade de collection par les signes suivants

Tuméfaction indurée

Signe de la fluctuation

Douleur lancinante

Chaleur localisée

Absence de douleur

La prise en charge de l'abcès chaud collecté comprend (Trois réponses)

Incision au point le plus déclive

Antibiothérapie systématique

Prélèvement de sang pour antibiogramme

Pansement compressif après incision

Sérovaccination antitétanique

Incision de la poche suivie d'une suture

L'abcès chaud se caractérise au stade de diffusion par les signes suivants (trois réponses)

Anorexie

Douleur

Frissons

Hyperleucocytose

Hypothermie

Rougeur

Parlant de l'abcès froid, les affirmations ci-dessous sont justes

L'incision systématique de l'abcès pour éviter la fistulisation

La poche de pus est constituée de trois couches distinctes

L'utilisation d'une antibiothérapie spécifique

Le foyer septique est loin d'être un mal de POTT

La ponction évacuatrice au point non déclive des abcès volumineux

Le traitement spécifique ne dure que 2 semaines

L'une des affections suivantes a pour point de départ une annexe de la peau.

Lymphangite

Abcès froid

Furoncle

Panaris péri unguéal

Le médecin fait le diagnostic d'une septicopyoémie chez monsieur DZ. Cette affection est

Un ensemble de foyers septiques à partir d'une septicémie

Une septicémie à partir de plusieurs portes d'entrée

Un est ensemble infectieux de sept portes d'entrée

Une furonculose purulente mal traitée (Non choisie aussi ?)

Les phases ci-dessous sont celles du phénomène de l'inflammation sauf une

La phase vasculaire

La phase cellulaire

La phase fibrillaire

La phase de réparation

Les infections ci-dessous sont directement liées à une porte d'entrée

Le panaris

La septicémie

La septicopyoémie

L'abcès froid

Le furoncle

La gangrène gazeuse (non choisie pourquoi ?)

La liste ci-dessous contient deux panaris superficiels ; lesquels (une réponse)?

Le panaris du pouce et le panaris sous unguéal

Le panaris sous unguéal et le panaris phlycténoïde,

Le panaris du pouce et le panaris phlycténoïde

Faire le bandage et l'immobilisation d'un membre en position fonctionnelle veut dire

Mettre le membre dans une position antalgique

Mettre le membre dans une position qui aide l'opérateur

Mettre le membre dans une position selon l'état du patient

Mettre le membre dans sa position physiologique

L'une des infections ci-dessous provoque un crochets digital au niveau de l'extrémité du membre supérieur du patient

Le phlegmon

La lymphangite

Le panaris péri unguéal

Le panaris du tissu cellulaire sous cutané

L'un des signes ci-dessous traduit une suppuration en cas d'abcès à l'examen physique

Une douleur exquise

Un œdème mou

Une fluctuation

Une chaleur circonscrite

La liste ci-dessous contient des facteurs locaux favorisant les furoncles (deux réponses)

Le surmenage

Le manque d'hygiène

Les fièvres éruptives

Les dermatoses prurigineuses

Les panaris du tissu cellulaire cutané

La baisse du taux de mélanine des mélanocytes

Les interventions infirmières ci-dessous permettent au patient de satisfaire son besoin d'éviter le danger dans la PEC du furoncle

Expliquer au patient la nécessité de contrôler sa glycémie (besoin d'apprendre document de 1ère A)

Demander au patient d'assurer quotidiennement son hygiène corporelle et vestimentaire

Veiller au respect de la prise de médicament (Besoin d'éviter le danger D'où à prendre en compte)

Faire des pansements chauds et humides sur le furoncle

Orienter le patient vers le médecin pour envisager le traitement chirurgical éventuel

Apprendre au patient à reconnaître l'évolution bénigne ou maligne du furoncle.

La liste ci-dessous comporte les formes cliniques de l'anthrax; lesquelles?

Anthrax circonscrit

Anthrax métastasique

Anthrax gazeux

Anthrax diffus

Anthrax œdémateux

Anthrax septicémique

Les ulcérations séparées d'aspect « écumoire » ou « nid » de guêpe s'observent dans l'une des pathologies ci-dessous; laquelle?

Les anthrax

Les phlegmons

Les furonculoses

Les septicopyoémies

L'anthrax a pour zone de prédilection

La nuque

L'aisselle

Le pubis

Le menton

La staphylococcie maligne de la face est une complication

De l'anthrax

Du phlegmon

Du furoncle

De la lymphangite

Les assertions suivantes concernant la gangrène gazeuse sont fausses (trois réponses)

C'est une nécrose locale des tissus, avec tendance à l'extension de proche en proche

Les germes en cause se développent souvent sur des plaies souillées de terre

Les agents pathogènes en cause sont uniquement des germes anaérobies

Les actes de soins sont loin d'être incriminés pour la porte d'entrée

Les troubles circulatoires font partie des facteurs favorisants

L'administration d'une antibiothérapie massive fait partie de l'arsenal de prévention

Les éléments ci-dessous font parties des facteurs favorisant la gangrène gazeuse (Trois réponses)

Garrot

Troubles circulatoires

Injection médicamenteuse

Plaie contuse souillée

Existence d'un diabète

Plaies de guerre

Les assertions ci-dessous relatives à la gangrène gazeuse sont justes , sauf deux : Lesquelles ?

Une nécrose des tissus avec extension spontanée du membre produisant du gaz

Les germes en causes produisent des toxines cytolytiques à l'origine de la nécrose cellulaire et des phénomènes de toxémies

Une mortification locale aboutissant à la nécrose des tissus, avec tendance à l'extension de proche en proche et production de gaz

Une lymphangite locale qui aboutit à la nécrose des tissus, avec tendance à l'extension et une production de gaz

Un phlegmon nécrosant du tissu musculaire à évolution rapide et extensive avec production de gaz au niveau des tissus

Un phlegmon du tissu péri amygdalien à évolution rapide et extensive avec production de toux et un gaz nauséabond

L'emphysème bronzé de Velpeau est l'une des formes cliniques de la gangrène gazeuse; laquelle?

Forme topographique

Forme étiologique

Forme symptomatique

Forme évolutive

La liste ci-dessous est celle des formes topographiques de la gangrène gazeuse sauf une, laquelle ?

Les formes progressives

Les formes circonscrites

Les formes diffuses

Les formes massives

Les symptômes de la gangrène gazeuse ci-dessous sont perçus à la palpation (trois réponses)

Peau ivoirine

Œdème luisant

Emphysème sous cutané

Tension artérielle effondrée

Refroidissement tégumentaire

Disparition du pouls

A l'exception de deux (02) (problème de compréhension) toutes les interventions ci-dessous sont celles de l'infirmier dans la prise en charge de la gangrène (deux réponses).

Décaper les tissus nécrosés jusqu'aux parties saines à chaque pansement

Etablir le rythme des pansements tous les deux jours dès la première rencontre

Donner les rendez-vous de pansement aux malades externes

Mobiliser régulièrement le membre atteint

Etablir un régime alimentaire aux patients diabétiques ou hypertendus

Prescrire et administrer le traitement médicamenteux

S'agissant de l'ostéomyélite aiguë, les assertions ci-dessous sont vraies (trois réponses)

C'est une inflammation suppurative de la moelle et de l'os

L'*Haemophilus influenzae* est le principal germe mis en cause

C'est une inflammation suppurative de l'os et du muscle

Le staphylocoque doré est retrouvé dans 80% à 96% des cas

Les enfants et les adolescents sont plus atteints que les adultes

Surtout les os courts sont généralement concernés par cette infection

L'ostéomyélite aigue se localise généralement au niveau de l'une des parties des os longs

La métaphyse

La diaphyse

Le condyle

L'épiphyse

La liste ci-dessous contient deux étiologies de l'ostéomyélite aigue ; lesquelles ?

Contusion des masses musculaires

Usage abusif des antibiotiques

Gangrène gazeuse

Furoncle

Anthrax

Angine

La liste ci-dessous contient des facteurs favorisant l'apparition de l'ostéomyélite aigue chez l'adolescent ; lesquels ?

Alimentation pauvre en oligo-élément

Hygiène défectueuse des mains

Porteur sain

Fatigue

Furoncles

Abcès froid

Dans l'ostéomyélite aigue, les lésions initiales osseuses siègent aux métaphyses des os longs car, ces zones sont

Très vascularisées

Moins vascularisées

Moins oxygénées

Très oxygénées

Trois des signes ci-dessous sont absents dans l'ostéomyélite aigue; lesquels?

Adénopathie inguinale

Douleur à la palpation

Etat général altéré

Œdème discret

Lymphangite

Arthrite

Dans la prise en charge de l'ostéomyélite du nourrisson, la traction du membre inférieur permet d'éviter une complication ; laquelle ?

Une luxation de la hanche

Une fracture secondaire

Une pseudarthrose

Une stase veineuse

S'agissant des brûlures, l'atteinte de l'aponévrose, selon la classification de Dypuytren des brûlures, correspond au

2ème degré

3ème degré

4ème degré

5ème degré

6ème degré

S'agissant des brûlures, l'atteinte du tissu osseux, selon la classification de Dypuytren des brûlures, correspond au

2ème degré

3ème degré

4ème degré

5ème degré

6ème degré

Le pronostic vital est réservé dans les brûlures dès que la surface corporelle brûlée dépasse

15 %

30 %

45 %

60 %

La formule: Poids (Kg) x4x SCB, utilisée dans la réanimation hydro électrolytique des brûlés est de BROWDER.

BAXTER

WALLACE

DYPUYTREN

Un brûlé à 30% reçoit 9 720 ml de soluté en deux (2) jours, son poids est

30 kg

35 kg

40 kg

45 kg

.54 kg

Un brûlé pesant 80 kg reçoit 7200 ml de soluté le deuxième jour de réanimation hydro électrolytique, sa surface corporelle brûlée est

40 %

45 %

50 %

55 %

La brûlure est considérée grave lorsqu'elle est supérieure à (deux réponses)

5 % chez l'enfant

10 % chez l'adulte

10 % chez l'enfant

15 % chez l'enfant

15 % chez l'adulte

20 % chez l'adulte

Dans les brûlures, la survenue éventuelle d'un choc hypovolémique est liée à

L'hémorragie causée par la brûlure

La diarrhée causée par la brûlure

La plasmorragie causée par la brûlure

La transpiration causée par la brûlure

Un brûlé à 30% reçoit un volume de 5 900 ml de solutés pour sa réanimation hydro électrolytique, son poids est donc

60 kg

65 kg

70 kg

75 kg

Un brûlé à 43,50 % reçoit 4 265 ml de solutés en 8 heures pour sa réanimation hydro électrolytique, son poids est donc

55 kg

65 kg

75 kg

85 kg

Un brûlé pesant 55 kg reçoit 4 265 ml de solutés en 16 heures pour sa réanimation hydro électrolytique, sa SCB est estimée à

49,30 %

59,30 %

69, 50 %

79, 50 %

Le poumon droit contient l'une des variétés de muscles ci-dessous, laquelle ?

Le muscle strié

Le muscle lisse

Le muscle horripilateur

Le muscle strié particulier

Les organes creux abdominaux contiennent l'une des variétés de muscles ci-dessous, laquelle?

Le muscle strié particulier

Le muscle strié

Le muscle lisse

La liste ci-dessus contient un élément appartenant au tissus nerveux, lequel?

Le tissu conjonctif

La muqueuse

Le sang

La cellule gliale

La liste ci-dessous contient deux tissus conjonctifs

L'épithélium

Le sang

Les seins

La fibula

Les fesses

La glande exocrine

Le neurone appartient à l'une des variétés de tissus ci-dessous, laquelle ?

Le tissu de régulation

Les tissus conjonctifs

Le tissu musculaire

Les épithéliums

La liste ci-dessous contient un tissu qui recouvre le conduit auditif, lequel ?

La muqueuse

Le tissu aréolaire

Le tissu réticulé

La séreuse

La mélanine est un pigment synthétisé par l'une des variétés de tissus ci-dessous, laquelle?

A- Le tissu de régulation B- Le tissu musculaire C- Le tissu épithélial D- Le tissu conjonctif

L'une des divisions cellulaires ci-dessous est dite réductionnelle, laquelle?

Mitose

Méiose

Amitose

Division directe

Parmi les phases de division cellulaire ci-dessous, la troisième phase est

La télophase

L'anaphase

La métaphase

D-La prophase

Une glande amphicrine est une glande

Exocrine

Mixte

D-Endocrine

Les chromosomes se trouvent dans l'une des parties suivantes de la cellule, laquelle?

Le noyau

Le cytoplasme

La membrane plasmique

Dans la cellule, les informations relatives à l'hérédité se trouvent au niveau

De la membrane plasmique

Du cytoplasme

Du noyau

De la membrane nucléaire

La liste des complications des fractures du cotyle ci-dessous contient trois complications tardives, lesquelles ? (Trois réponses)

L'hématome sous-péritonéal

La nécrose ischémique de la tête fémorale

L'irréductibilité d'une luxation postérieure

Les paralysies sciatiques

La coxarthrose post-traumatique ;

Les ossifications périarticulaires.

S'agissant des causes pré disposantes des contusions abdominales, l'une des causes ci-dessous est anatomique ; laquelle ?

Relâchement de la paroi abdominale

Splénomégalie et ou hépatomégalie

Malformation de la paroi abdominale antérieure

Choc par percussion abdominale

La liste ci-dessous contient² trois éléments du syndrome de l'hémorragie interne; lesquels ?

Hépatomégalie

Abdomen tendu

Tension artérielle effondrée

Polypnée superficielle

Bradypnée superficielle

Plastron appendiculaire

La liste ci-dessous contient les trois types de causes pré disposantes des contusions abdominales ; lesquelles ?

Les causes pariétales

Les causes anatomiques

Les causes viscérales

Les causes physiologiques

Les causes pathologiques

Les causes accidentelles

La rupture de l'un des viscères pleins ci-dessous dans les contusions abdominales donne une ponction péritonéale négative; lequel ?

Le foie

La rate

Le pancréas

Le rein

La rupture post contusionnelle d'un des viscères pleins ci-dessous est cause d'hémorragie interne et de perturbation de la production du glucagon et de l'insuline ; lequel ?

Le foie

La rate

Le pancréas

Le rein

Les signes physiques ci-dessous sont en faveur d'une perforation intestinale dans les contusions abdominales ; lesquels ? (Trois réponses)

Immobilité diaphragmatique (respiration costale supérieure)

Comblement du cul de sac de Douglass

Contracture abdominale (ventre de bois)

Malade angoissé prostré adynamique

Disparition de la matité hépatique

Malade agité souffrant d'une soif intense

S'agissant des contusions abdominales, l'une des lésions anatomopathologiques ci-dessous expose à une gangrène ischémique ; laquelle ?

Les lésions des viscères pleins

Les lésions pariétales

Les lésions des mésentères

Les lésions des viscères creux

La surveillance clinique d'une contusion abdominale se fait chaque

15 minutes

30 minutes

45 minutes

1 heure

Dans la contusion abdominale, l'on perfuse le malade avec modération pour

Ne pas perturber les examens hématologiques

Ne pas masquer une hémorragie interne

Assurer une surveillance adéquate

Dissiper un choc éventuel

Les signes fonctionnels ci-dessous permettent de suspecter précocement une perforation intestinale dans les contusions abdominales sauf un ; lequel ?

Le vomissement

L'émission sanglante anale

L'arrêt des matières et des gaz

La douleur spontanée ou intermittente

L'une des variétés de pieds bots ci-dessous est plus fréquente chez les garçons que les filles; laquelle?

Pied bot métatarsus varus

Pied bot varus équin

Pied bot valgus

Pied talus

S'agissant des pieds bots, la déviation du pied en dehors par rapport à l'axe du corps est :

Le pied bot métatarsus varus

Le pied bot varus équin

Le pied bot valgus

Le pied talus

S'agissant des pieds bots, l'étalement exagéré des orteils portés en dedans est

Le pied talus

Le pied bot valgus

Le pied bot varus équin

Le pied bot métatarsus varus

S'agissant des pieds bots, lorsque la plante du pied est tournée vers l'intérieur, l'on parle de

Pied bot varus

Pied bot valgus

Pied bot métatarsus

Pied bot équin

Pied talus

S'agissant des pieds bots, lorsque la pointe du pied est dirigée vers le bas, l'on parle de

Pied talus

Pied bot équin

Pied bot varus

Pied bot valgus

Pied bot métatarsus

S'agissant des pieds bots, lorsque le pied est en hyperflexion tourné vers le genou, l'on parle de

Pied talus

Pied bot équin

Pied bot varus

Pied bot valgus

Pied bot métatarsus

La côte cervicale est

Une variété de volet costal

Une luxation congénitale de la côte

Une luxation post traumatique de la côte

Une malformation de côte en surnombre

La syndactylie est

Une intervention chirurgicale sur les doigts

Une union de deux ou plusieurs doigts

Une insensibilité des doigts

Aucune des propositions

Le pouce bifide est

Une polydactylie du pouce

Une infection chronique du pouce

Une malformation par manque du pouce

Aucune des propositions

La maladie de Madelung est aussi appelée

Radius curvus

Syndactylie

Polydactylie

212) 6W2 F—férents types de choc font suite aux traumatismes violents, sauf un (01) ; lequel ?

A. 6†ö2 ÷ — atoire

B. 6†ö2 €ypovolémique

C. 6†ö2 G aumatique

les complications secondaires des traumatismes du bassin sont : cochez les deux (02) bonnes réponses.

Ouverture cutanée

Thromboembolie

Lésions du rectum

Infection

Lésions de l'urètre

Le diagnostic différentiel de la luxation antéro-interne de l'épaule se fait avec les lésions suivantes, sauf une ; laquelle ?

Fracture du col de l'omoplate

Fracture du col de l'humérus.

Fracture de la grosse tubérosité.

Sur les lieux de l'accident, le rôle de l'infirmier en cas de suspicion de fracture consiste à : (choisir une seule réponse)

a. • — &W" ÆR 6† × ÷ — atoire.

b. "aire une immobilisation provisoire.

c. "aire un pansement aseptique.

216) Les symptômes cités ci-dessous évoquent le syndrome de wolkman, exceptés deux (02) ; lesquels ?

a. ~ÆN†ÖP

b. "Ž–Ö throse

c. "Ž–Ö FöÖP

d. "F÷VÆWW" ² ÷R Ò f—`e de l'avant-bras ou la main.

e. "—× ÷FVæ6R `onctionnelle

Le nursing du malade hospitalisé consiste à : (choisir une seule réponse)

a. "aire le prélèvement pour de le bilan préopératoire.

b. "aire la toilette et la prévention des escarres.

c. "aire la préparation physique pour une éventuelle opération.

Un patient présente plusieurs fractures sur toutes les parties de son membre supérieur droit ne mettant pas en jeu le pronostic vital. Ce patient est selon vous :

a. •Vâ öÇ—G aumatisé

b. •Vâ öÇ—G aumatisé et un polyfracturé.

c. •Vâ öÇ—g acturé.

e. "Ö—6R Vâ Æ 6R l'VæR Æ VR FR öö× &W76—ôâ vec des vis.

L'évolution favorable en cas de fracture de Pouteau-colles se fait vers la consolidation en : (choisir la bonne réponse)

a. " " Öö—2 Ò 2 Öö—0

b. " 2 Öö—2 B Öö—0

c. " B R 6VÖ —æW2 6÷W2 .—6W ve d'un traitement.

Parmi les signes ci-dessous énumérés, 03 (trois) sont des signes généraux du Mal de Pott ; lesquels ?

a. •& —FWW" Ö ' ^—R GR achis

b. " 7FŽ—æ—P

c. "fièvre vespérale

d. "vibrosité

e. "ÇN— ation de l'état Général

f. "6öçG acture des muscles paravertébraux.

les complications secondaires des traumatismes du bassin sont : cochez les deux (02) bonnes réponses.

a. "÷W`erture cutanée

b. •F‡&öÖ&öVÖ&öÆ—P

c. "Î—6—öç2 GR &V7GVĐ

d. "—æ`ection

e. "Î—6—öç2 FR É'W.‡G&P

Le diagnostic différentiel de la luxation antéro-interne de l'épaule se fait avec les lésions suivantes, sauf une ; laquelle ?

a. "rature du col de l'omoplate.

b. "rature du col de l'humérus.

c. "rature de la grosse tubérosité.

Sur les lieux de l'accident, le rôle de l'infirmier en cas de suspicion de fracture consiste à : (choisir une seule réponse)

a. •.— &W" ÆR 6† × ÷ — atoire.

b. "aire une immobilisation provisoire.

c. "aire un pansement aseptique.

Les symptômes cités ci-dessous évoquent le syndrome de Wolkman, exceptés deux (02) ; lesquels ?

a. ~ÆN†ÖP

b. "Ž—Ö throse

c. "Ž—Ö FöÖP

d. "F÷VÆWW" 2 ÷R Ò f—`e de l'avant-bras ou la main.

e. "—x ÷FVæ6R `onctionnelle

Le nursing du malade hospitalisé consiste à : (choisir une seule réponse)

a. "aire le prélèvement pour de le bilan préopératoire.

b. "aire la toilette et la prévention des escarres.

c. "aire la préparation physique pour une éventuelle opération.

Un patient présente plusieurs fractures sur toutes les parties de son membre supérieur droit ne mettant pas en jeu le pronostic vital. Ce patient est selon vous :

a. •Vâ öÇ—G aumatisé

b. •Vâ öÇ—G aumatisé et un polyfracturé.

c. •Vâ öÇ—g acturé.

le traitement d'une fracture déplacée comporte deux (02) temps principaux

a. "Æ 6öçFVçF—öà

b. "Æ .Ž—GV6 F—öà

c. "Æ .—GV7F—öà

d. "Àostéosynthèse

e. "Æ G action-suspension

La fracture du corps du radius et du cubitus sans déplacement se traite par : (choisir les deux 02

bonnes réponses) ???? idem

a. •. –GV7F –öâ Ö àuelle

b. •. Ž –GV6 F –öâ

c. " Æ –6 F –öâ l'Vâ Î'G&R ÆR ÆöæR GR ' as

d. •. –GV7F –öâ 6† — urgicale

e. "Ö —6R Vâ Æ 6R l'VæR Æ VR FR 6ö× &W76 –öâ vec des vis.

Parmi les signes ci-dessous énumérés, 03 (trois) sont des signes généraux du Mal de Pott ; lesquels ?

a. •& –FWW" Ö ' ^ –R GR achis

b. " 7FŽ –æ –P

c. "fžÈvre vespérale

d. "v – bosité

e. " ÇN — ation de l'état Général

f. "6öçG acture des muscles paravertébraux.

Dans le traumatisme crânien modéré, le score de Glasgow est de :

A = 9 à 12

B = 13 à 15

C = 3 à 8

Parmi ces signes émanant du score de Glasgow, lequel appartient à la meilleure réponse motrice ?

l'appel ou au bruit 3

Réponse appropriée 5

Mouvement de retrait 4

Dans l'étiologie des sciatalgies, ces propositions ci-dessous énumérées sont exactes ; sauf une, laquelle ?

A. •VæR 7 öæG –ÆöF —66 —FR –æ`ectieuse

B. •Vâ 6 æ Â ÆöÖ& —&R prandi

C. •VæR †W nie discalé

D. •Vâ 6 æ Â ÆöÖ& —&R .—G. –6•

Parmi ces examens paracliniques, un seul permet de faire l'exploration neurologique et ostéo-articulaire complète dans les sciatalgies ; lequel ?

A. •6 7&÷ adiculographie

B. •66 ææW" GR achis

C. " –Ö vW ie à résonnance magnétique (IRM)

Indiquez les éléments exacts du score de Glasgow consécutif à la meilleure réponse verbale au cours de l'examen neurologique.

A. •`olontaire, sur commande 6

Adaptée orientée à la douleur 4

Aucune 1

D. "Vâ Pxtension (décérébration) 3

Un traumatisé de la voie publique qui ouvre les yeux à la douleur, émet des mots qui sont incompréhensibles et fait une flexion des bras à la douleur de manière anormale, présente comme score de Glasgow

A = 8

B = 9

Parmi les éléments du principe des quatre tuyaux suivants, deux sont des moyens de prévention du syndrome de Mendelson et l'œdème cérébral.

- a. • @ubulure d'oxygénation
- b. • erfusion par voie veineuse
- c. • 6öæFR W inaire
- d. • 6öæFR æ 6öv 7G ique

Les lésions suivantes, pouvant être observées au niveau du cerveau après un traumatisme crânioencéphalique, sauf deux :

- a. • Vâ ÆN†ÖP
- b. • VæR V66€ymose
- c. • VæR 6öÖÖ÷F-öà
- d. • VæR VÖ& ' ure

Les signes ci-dessous sont des signes méningés après un traumatisme crânioencéphalique, sauf deux :

- a. • & -FWW" 6W vicale
- b. -Ž-Ö— Î-v-P
- c. —`omissement incoercible
- d. -Ðyosis
- e. —&VÎ&6†VÖVçB 7 †-æ7N— ien

Les pathologies ci-dessous sont des causes d'une sciatique, sauf deux

- a. "yistes méningés
- b. "Àymphangite
- c. "Ö Â FR ott
- d. "Æ— öÖP
- e. • @umeurs osseuses

Toutes les interventions suivantes sont à faire chez le traumatisé crânien, exceptée une : Laquelle ?

- a. " .-6-W" É.—F B FR 6öç66-Væ6P
- b. " .-6-W" ÆW2 `onctions vitales
- c. •&V6†W&6†W" ÆW2 6-væW2 Þ-æ-æ~—2 †>— † Î-W0, raideurs de la nuque)
- d. "aire une ponction de l'hématome
- e. •&V6†W&6†R VæR Ðydriase.

Le score de Glasgow permet d'évaluer l'état de conscience et de suivre son évolution à partir des trois éléments énumérés ci-dessous sauf un : lequel ?

- a. "÷W`erture des yeux
- b. "ÆR 6-væR FR & &-ç6¶•
- c. "Àouverture des yeux aux stimulations verbales
- d. "Àappréciation de la réponse motrice à la parole et ou à la douleur.

Les fractures et les luxations du rachis sont causées par les mouvements énumérés ci-dessous, sauf un : lequel ?

- a. "ÆW2 Ö÷W`ements d'hyperflexion du rachis
- b. "ÆW2 Ö÷W`ements d'hyperextension du rachis
- c. "ÆR 6†ö2 F—&V7@

d. "ÆR 6†ö2 -æF—&V7@

e. "ÆW2 Æöæ~-W2 6÷W2ÖÖ ines

Toutes les propositions ci-dessous concernant l'étiologie des sciatalgies sont exactes, sauf une. Laquelle ?

a. "†W nie discalé

b. •Vâ 6 æ Â ÆöÖ& —&R .—G.-6•

c. •VæR 7 öæF-F—66—FR -æ`ectieuse

d. •Vâ 6 æ Â ÆöÖ& —&R prandi

e. •VæR GVÖWW" ÷76WW6P.

La liste ci-dessous est celle des étiologies des sciatalgies, sauf deux éléments: Lesquels ?

a. •Vâ 7 -æ &-f-F

b. Une spondilodiscite infectieuse

c. •VæR GVÖWW" ÷76WW6P

d. Une hydrocéphalie.

e. Une hernie discale

Pour soulever un traumatisé du rachis avec le maximum de sécurité, il faut pratiquer les gestes ci-dessous, sauf un. Lequel ?

a. "Ö -çFVæ—" 6öÆ-FVÖVçB WB udemment la tête en arrière

b. •F—&W" 7W" ÆW2 6†Pvilles

c. "fl-6†—" Æ N§FP

d. •6 —6—" ÆR 6÷ ps sous le tronc et sous les cuisses

Les hémorragies cérébro-méningées ci-dessous sont les complications de la fracture du crâne sauf deux (2) ; lesquelles ?

a. "Ž-Ö FöÖR Pxtradural

b. "Væv vVÖVçB >—.-' al

c. "Ž-Ö÷' agie intradurale

d. "Væv vVÖVçB >—.-&VÆÆWW€

e. "Ž-Ö FöÖR 6÷W2 GW al

La radiographie du crâne d'un traumatisé de la base du crâne présente les symptômes ci-dessous sauf un. Lequel ?

a. • aralyse faciale

b. •@rouble de l'équilibre

c. "÷F÷' agie

d. •@rouble de l'audition

e. •&†-æ÷'&Ž-P

Dans le traumatisme crânien modéré, le score de Glasgow est de ;

a. "

b. " 2 P

c. "2 €

Parmi ces signes émanant du score de Glasgow, lesquels appartiennent à la meilleure réponse motrice ?

A l'appel ou au bruit

Réponse incohérente

c. "N-6÷ tication

Les signes fonctionnels en cas de fracture du tiers moyen de la clavicule sont : (choisir 2 bonnes réponses)

- a. -F÷VÆWW" f—`e et persistante
- b. -N§FR -æ6Æ-î-R GR ?GN' GFV-ç@
- c. —× ÷FVæ6R `onctionnelle
- d. - & —76VÖVçB GR Öö-væöâ FR É.— VÆP
- e. -Ž-Ö FöÖR G.‡2 -× ÷ tant

La méthode orthopédique dans les bases du traitement en cas de fracture de la clavicule obéit à : (choisir une seule réponse)

- a. —VæR .-GV7F-öâ 6÷W2 æW7FŽ—6-R ~-î— ale à foyer ouvert
- b. —Vâ & æF vR Vâ ‡V—B FR 6†-fg&R WB ÆW2 ' anches de 8 se croisent dans le dos.
- c. —VæR 6öçFVçF-öâ " ' &ö6†R FR ¶—'66†æW" -çG&öGV—FR " É&Pextrémité de l'os.

Le rôle de l'infirmier sur les lieux de l'accident en cas de suspicion de fracture consiste à : (choisir une seule réponse)

- a. ' `aire une réduction provisoire
- b. — .— &W" ÆER 6† × ÷ — atoire
- c. " `aire une contention provisoire

Les symptômes ci-dessous énumérés sont ceux du syndrome de Wolkman, exceptés deux (02) ; lesquels ?

- a. -Ž-Ö FöÖP
- b. ™ÆN†ÖP
- c. -F÷VÆWW" ÇW2 ÷R Öö-ç2 f—`e de l'avant-bras ou la main
- d. - throse
- e. —× ÷FVæ6R `onctionnelle

Relevez parmi les complications suivantes des fractures du fémur, celles qui sont secondaires et générales : (choisir deux bonnes réponses)

- a. -Î—6-öç2 `asculo-nerveuses
- b. - 66-FVçG2 FR N-7V&—GW0
- c. -6†ö2 G aumatique et hémorragique
- d. - G&÷ †-R Đusculaire
- e. — †Î-&—FR WB VÖ&öÆ-P

Parmi les antibiotiques indiqués ci-dessous, lesquels sont recommandés dans le traitement antituberculeux du mal de pott ? (choisir trois bonnes réponses)

- a. - Ööxicilline
- b. — ifampicine (RIF/R)
- c. " &Vç† F†-æR &Vç§-Ç -æ-6-ÆÆ-æP
- d. Ž—F† Ö utol (EMB/E) + streptomycine (S)
- e. —6öæ- †-FR „, "ä, ô, •
- f. — yrazinamide (PZA/Z)

Les premiers signes d'une insuffisance circulatoire sont à reconnaître par l'infirmier(ère) dans la surveillance d'un malade choqué, sauf deux, lesquels ?

- a. -ÆER 6-væR FR °ernig

b.-Æ g.— VVæ6R 6 &F- VP

c.-Æ F—W.‡6P

d.-É&ö&àubilation

e.-É.—F B FR 6öç66—Væ6P

f. La cyanose

Il faut dans la CAT devant une luxation de l'épaule récente : (choisir 3 bonnes réponses)

a.-`aire une ostéosynthèse de la région atteinte

b.— .— &W" 7-6†öÆöv— VVÖVçB ÆER Ö Æ FP

c.-`aire des radiographiques de face et de profil pour une confirmation du diagnostic

d.-N— —7FW" ÆW2 6ö× Æ-6 F-öç2 æWW&ò×`asculaires

e.— &ö>-FW" É&-çFW'&öv Fö—&R 7W" ÆW2 6—&6öç7F æ6W2 FR É& 66-FVç@

f. Faire une immobilisation provisoire

L'hématome et l'atteinte du nerf sciatique sont deux complications des fractures du fémur :

a- Secondaires

b- Tardives

c- Immédiates

Parmi les complications ci-dessous, une seule fait partie des complications urinaires en cas de traumatisme du bassin, laquelle ?

a- Rupture des urètres

b- Rupture intra-péritonéale de la vessie

c- Hémorragie de l'urètre.

Les éléments ci-dessous font partie des premiers signes à reconnaître par l'infirmier dans la surveillance du patient choqué sauf deux, lesquels ?

a- Température

b- Etat cutané

c- Remplissage des veines

d- Fréquence cardiaque

e- Etat respiratoire

Parmi ces complications, deux sont souvent immédiates en cas de traumatisme du bassin : lesquelles ?

a- Atteinte artérielle

b- Atteinte vésicale

c- Embolies graisseuses

d- Atteintes nerveuses

e- Blessures intestinales

Les pathologies ci-dessous sont considérées comme des maladies infectieuses en chirurgie (deux réponses)

Diarrhée parasitaire

Accès palustre

Septicémie à perfringens

Diabète

Panaris

Toux

Le prélèvement de sang pour l'hémoculture doit se faire au moment des frissons car à cet instant

Le germe est dans le sang

Le germe est dans la porte d'entrée

Le germe se multiplie

Le germe est plus gros

Les signes ci-dessous sont dits physiques dans la septicémie (deux réponses)

Hépatomégalie

Splénomégalie

Cardiomégalie

Arthralgie

Langue sèche

Oligurie

264)- L'antibiogramme s'accompagne souvent avec l'un des examens biologiques ci-dessous

Numération formule sanguine

Hémoculture

Groupage sanguin

265)- La septicémie peut avoir pour porte d'entrée (deux réponses)

Un avortement provoqué

Une barbe

Un diabète

Un foyer aseptique

Un foyer septique

Une rhinite allergique

266)- Une septicémie est

Une décharge répétée de germes dans le sang

Une décharge de germes dans un organe

Une multiplication de germes dans un tissu

Une décharge de germes dans toutes les cellules

267)- L'antibiogramme consiste à tester

La présence du germe dans l'organisme

La réaction du germe face à la biologie de l'hôte

La résistance du germe aux antibiotiques

La résistance du germe aux probiotiques

268)- L'incision d'un abcès collecté se fait au point le plus déclive signifie

Le point le plus bas

Le point le plus haut

Le point le plus latéral

Le point le plus médian

269)- La septicémie a une apparition

Pernicieuse

Brutale

Intermittente

Progressive

270)- La liste ci-dessous contient deux signes physiques de la septicémie, lesquels ?

Arthralgie

Hyperthermie

Splénomégalie

Urines rares et foncées

Pouls très rapide

Eruptions cutanées

271)- Le furoncle a pour foyer septique

A- Une lymphangite

B- Une septicémie

C- Un panaris maltraité

D- Aucune des propositions

272)-La prise en charge étiologique d'un abcès froid dure

Moins de 6 mois

6 mois au moins

Plus de 6 mois

Aucune des trois propositions

273)- L'abcès froid est une infection causée par

Le bacille d'Eberth

Le bacille de Koch

Le bacille de Nicolaier

Le colibacille

274)- Le crochet digital semi fléchi est un signe physique de l'une des pathologies ci-dessous, laquelle ?

La lymphangite

Le panaris péri-unguéal

L'abcès lymphatique

Le phlegmon

275)- Les parties du corps humain ci-dessous peuvent être le siège d'une lymphangite (trois réponses)

A- Les membres

B- Les seins

C- La nuque

D- Le scrotum

E- L'abdomen

F- La langue

276)- Dans l'évolution des maladies infectieuses, une septicopyoémie est une complication

A- Régionale

B- Locorégionale

C- Générale

D- Locale

277)- S'agissant des facteurs favorisant des furoncles, les facteurs ci-dessous sont généraux (Trois éléments de réponse)

A- Malnutrition

B- Manque d'hygiène corporelle

C- Fièvres éruptives

D- Les frottements ou irritations répétées

E- Le diabète le plus souvent

F- Agression chimique de la peau

278)- Les actions ci-dessous font partie de la prise en charge du furoncle

A- Antibiothérapie systématique

B- Presser le furoncle

C- Rechercher systématiquement un diabète

D- Faire un pansement avec un antiseptique

E- Faire un antibiogramme

F-Conduire le patient chez le cardiologue

279)-La zone de prédilection de l'anthrax est

A. La nuque

B. L'aile du nez

C. Le dos

D. La fesse

280)- La liste ci-dessous contient des porteurs sains dans une structure sanitaire, lesquels ?

L'IDE/SF

L'informaticienne du CHU

Le fauteuil du Directeur de l'hôpital

L'agent d'hygiène du CHR

Le brassard du tensiomètre

Le visiteur

281)- S'agissant de l'abcès froid, des assertions ci-dessous sont justes, lesquelles ?

L'abcès froid est un abcès chaud refroidi

Le mal de POTT est un foyer septique de l'abcès froid

L'abcès froid a pour foyer septique le phlegmon

Le prélèvement de sang se fait au moment des frissons

Le drainage de l'abcès froid se fait au point déclive

La prise en charge thérapeutique dure 6 mois au moins

282)-La chaleur humide utilisée dans la stérilisation est produite avec

Le formol

Le poupinel

Le paragerme

L'autoclave

283)-Les éléments ci-dessous peuvent être stérilisés avec le poupinel

Blouses opératoires

Plateau inox

Boite à pansement

Salle opératoire

Champs opératoires

Alèze plastique

284)-Les signes ci-dessous sont observés dans l'abcès chaud au stade de collection

Tuméfaction indurée

Signe de la fluctuation

Douleur lancinante

Absence de douleur

Chaleur localisée

285)-La prise en charge de l'abcès chaud collecté comprend

Antibiothérapie systématique

Incision au point le plus déclive

Prélèvement de sang pour antibiogramme

Pansement compressif après incision

Sérovaccination antitétanique

Incision de la poche suivie d'une suture

286)-S'agissant de l'abcès froid, les assertions ci-dessous sont vraies

L'utilisation d'une antibiothérapie spécifique

L'incision systématique de l'abcès pour éviter la fistulisation

La poche de pus est constituée de trois couches distinctes

Le pus est jaune et constitué de débris caséeux

Le foyer septique est loin d'être un mal de POTT

Le traitement spécifique dure au moins 6 mois

La notion de terrain en infectiologie fait allusion à

La gravité de l'infection considérée

L'état physiologique de l'organisme infecté

L'anatomie de l'organisme du malade

La virulence du germe en cause

Les infections ci-dessous sont directement liées à une porte d'entrée

La septicémie

La septicopyoémie

Le panaris

Le furoncle

La gangrène gazeuse

L'abcès froid

La liste ci-dessous contient des panaris superficiels. Lequels ?

Panaris péri-unguéal,

Panaris sous unguéal,

Panaris phlycténoïde,

Panaris osseux ou articulaires

Panaris des gaines synoviales des fléchisseurs

Faire le bandage et l'immobilisation d'un membre en position fonctionnelle veut dire

Mettre le membre dans une position antalgique

Mettre le membre dans sa position anatomique

Mettre le membre dans une position qui aide l'opérateur

Mettre le membre dans une position selon l'état du patient

ETUDE DE CAS

CAS CLINIQUE N°1

Vous êtes IDE nouvellement affecté au CHR de Katiola au service de Chirurgie. Vous recevez pour brûlures lors d'un incendie de chasse, M. HILI G. âgé de 25 ans en provenance de Djélékaha village de la sous-préfecture. Il est agité et réclame sans cesse à boire.

Après un examen somatique, le chirurgien relève ces faits :

La brûlure couvre la tête, le cou, la moitié du dos et le membre supérieur gauche

Des douleurs de la ceinture pelvienne accompagnée d'oligurie

Le pouls est ralenti

La respiration est lente

L'atteinte de toutes les couches de la peau (épiderme, derme, hypoderme) détruisant toute la couverture cutanée

L'interrogatoire a révélé que M.Hili est drépanocytaire

L'aide-soignante a noté les constantes ci-dessous :

TA= 8/5 cm Hg

T°= 37°5 C

Il pèse 58 kg

Et mesure 1m75.

Quelle est la surface corporelle brûlée selon la règle des 9 de Wallace ?

SCB : Tête et cou (9%) + ½ Tronc (18/2=9%) + Mbre (9%)

AN. SCB = 9+9+9 = 27%

17%

27%

37%

47%

Calculez l'indice de brûlure selon la Baux

LB= %SCB + ÂGE + TARE

AN.

LB = 27 + 25+15 =67

47

57

67

77

Emettre un pronostic en rapport avec la brûlure de M.HILI

50 < IB= 67 <100

N'a pas de chance de survivre

A une chance sur deux de guérir

Toutes les chances de vivre

Quel est le degré de brûlure dans la classification des 6 de Dypuytren ?

2ème degré superficiel

2ème degré profond

3ème degré

4ème degré

Calculer selon la règle d'Evans, dans le traitement du choc de M. Hili, la quantité de solutés à lui perfuser dans les 24 premières heures de son arrivée.

3132 ml

4132 ml

5132 ml

6132 ml

Faites la répartition temporelle de la quantité de solutés à perfuser en 8 heures et 16 heures

Les 8 premières heures (moitié de la quantité totale)

1283 ml

2000 ml

2566 ml

5132 ml

Les 16 heures suivantes (le reste de soluté)

1283 ml

2000 ml

2566 ml

4132 ml

5132 ml

7) Déterminez le débit de chaque quantité de solutés à perfuser en 8 heures

105 gttes/min

106 gttes /min

107 gttes/min

8) Déterminez le débit de chaque quantité de solutés à perfuser en 16 heures

53 gttes/min

54 gttes /min

55 gttes/min

Déterminez la quantité de soluté Macromoléculaire

1560 ml

1566 ml

2550 ml

3566 ml

Déterminez la quantité de soluté bicarbonate

850 ml

891,5 ml

895 ml

9000 ml

Déterminez la quantité de soluté Sérum glucosé et d'électrolytes

2000 ml

2674,5 ml

3200 ml

3566 ml

Sur quels éléments porte la surveillance de ce brûlé ?

GE/Frottis

NFS/VS

TA

FR

ECBU

<

Pendant combien de temps, faut-il éviter tout apport oral chez M. Hili en cours de traitement ?

24 heures

48 heures

72 heures

CAS CLINIQUE N°2

Mlle Sulié T. étudiante en Licence3 communication à la FLASH de l'Université A.O de Bouaké est amenée aux urgences chirurgicales pour douleurs abdominales brutales, constantes avec nausées et vomissements.

Elle est en surpoids et est stressée par rapport à l'examen de certification.

L'auxiliaire relève les constantes suivantes :

Poids = 75 kg

Taille = 155 cm

Âge = 22 ans

Pouls = 100b/min

Fièvre = 38°5 C

Tension artérielle = 11/08 cm Hg

L'interrogatoire révèle que :

La douleur est aggravée par la toux et les mouvements

Les vomissements sont alimentaires ou bilieux

Le trouble du transit est constitué de constipation

A l'examen, le médecin note :

Langue saburrale

Conjonctives colorées

La palpation douce du cadran inférieur droit de l'abdomen réveille la douleur

La flexion forcée de la cuisse droite sur l'abdomen exacerbe la douleur

Ailleurs sans particularités.

En attente de la réalisation des examens de l'intervention, le médecin lui prescrit :

Paracétamol 500mg comp. 2cpx2/jour

Spasfon en perfusion : 1 amp.x 2/jour

Ceftriaxone 1g : 1 amp.x 2/jour en IVD

Hydrosol ployvitaminé inj. : 4 amp.x 2/jour

Sérum glucosé 500 ml : 1 fl.x2/jour

NB : 1 ampoule de spasfon = 10 ml

1 ampoule de HPV = 5ml

QUESTIONS

De quoi souffre Mlle Sulié T. ?

Ulcère gastroduodénal

Occlusion intestinale aiguë

Appendicite aiguë

Péritonite généralisée

Quels sont les éléments qui ont permis de poser le diagnostic ? (choisir 3 éléments)

La palpation douce du cadran inférieur droit de l'abdomen réveille la douleur

La flexion forcée de la cuisse droite sur l'abdomen exacerbe la douleur

Tension artérielle = 11/08 cm Hg

Fièvre = 38°5 C

Langue saburrale

Conjonctives colorées

Quels sont les examens à faire pour confirmer le diagnostic ? (choisir 3 examens)

KOP

ECBU

ASP

Echographie abdominale

NFS/VS

Quels sont les diagnostics différentiels chirurgicaux ? (choisir 3 éléments)

Grossesse extra-utérine

Torsion de kyste

Gastroentérite

Colique néphrétique

Constipation opiniâtre

Hépatite

Quelles sont les probables causes de la pathologie de Mlle Sulié T. ? (choisir 4 réponses)

Parasitoses intestinales

Corps étrangers

Coprolithes

Infections

Obésité

Stress

Quel est le débit de la perfusion Mlle Sulié T. ?

14 gouttes/min

15 gouttes/min

22 gouttes/min

44 gouttes/min

Donnez 3 contre-indications de la perfusion ?

Anasarque

Œdème aigu des poumons

Anémie

Déshydratation

Hyperthermie

Coma

Formulez deux diagnostics infirmiers en rapport avec la pathologie ?

Hyperthermie reliée à la maladie

Risque de déshydratation causé par les nausées et vomissements

Douleur abdominale causée par la pathologie

Difficultés respiratoires dues à son hospitalisation

Identifiez les deux besoins prioritaires à satisfaire chez la malade ?

Besoin de manger et boire

Besoin de maintenir la température corporelle dans les limites normales

Besoin d'éviter le danger

Besoin de s'occuper en vue de se rendre utile

Pour déterminer le groupe sanguin de Mlle S.T., on a utilisé les globules et les sérums tests (Anti-A, Anti-B, Anti-A+B et Anti-D).

Quelle est la méthode qui a été utilisée ?

La méthode de Simonin

La méthode Simonne

La méthode de Beth Vincent

CAS CLINIQUE N°3

M. ZOGA est hospitalisé chambre 7 lit 3 en Urologie du CHU de COCODY où vous êtes IDE en fonction. Le patient est âgé de 74 ans. Il est marié et père de huit (8) enfants. Il présente une dysurie et une pollakiurie nocturne avec retard du jet souillant souvent ses vêtements. Le toucher rectal pratiqué par le chirurgien de garde confirme le diagnostic.

Q1- De quelle affection s'agit-il ?

Adénome prostatique

Rétrécissement urétral

Rétention urinaire

Fistule vésicale

Q2- Selon le modèle conceptuel de Virginia Henderson, deux (2) besoins prioritaires sont perturbés chez M. ZOGA. Lesquels ?

Éliminer

Être propre, soigné et protéger ses téguments et phanères

Éviter le danger

Manger et boire

Respirer

Q3- Quels sont les examens para cliniques nécessaires au diagnostic du mal de M.ZOGA ?

ECBU

Glycémie

Echographie

Urographie intra veineuse

Urétro cystographie rétrograde mictionnelle

Abdomen sans préparation

Q4- Après l'intervention chirurgicale, quelles sont les activités infirmières à mener dans les 24 premières heures ?

Surveiller les signes vitaux

Faire le pansement

Vérifier le bon écoulement et début des perfusions

Administrar le traitement prescrit

Dresser le lit du malade

Rechercher les signes de caillottage et des sondes

Q5) Quels conseils donnerez-vous à M.ZOGA à sa sortie de l'hôpital ?

Lui dire d'arrêter des rapports sexuels

L'informer qu'il ne peut plus procréer

Lui dire de respecter les rendez-vous pour les pansements

De limiter la consommation des liquides le soir

De se faire vacciner

D'utiliser des aphrodisiaques régulièrement

CAS CLINIQUE N°4

M.SECONGO D. âgé de 60 ans est admis au service d'urologie du CHU/Bké dans lequel vous exercez en tant qu'IDE.

Il est marié et père de trois enfants. Il est retraité de la fonction publique. Il est arrivé à 7h00 à l'hôpital

L'Aide-Soignante a relevé les constantes suivantes :

T°= 37°2 C

TA= 145/80 mmHg

Poids= 75 Kg

Taille= 175 cm

FR= 20 c/min

Pouls= 80 bat/min

Le médecin-chirurgien après examen a noté :

Douleurs à la palpation de l'abdomen

Présence de globe vésical

Masse hypogastrique remontant à l'ombilic

Alors que l'interrogatoire mené a révélé :

Impossibilité brutale d'émettre des urines depuis 20 heures

Douleur sus-pubienne de plus en plus intense

Des besoins impérieux d'uriner devenant douloureux et n'aboutissant qu'à l'émission de quelques gouttes

Le diagnostic présomptif est : une rétention d'urine

Quelle est la pathologie en cause ?

Adénome de la prostate

Rétention urinaire aiguë

Rétention urinaire chronique

Qu'est-ce qui caractérise la rétention urinaire aiguë ?

Impossibilité complète d'uriner qui se traduit par brutale et totale d'uriner

Impossibilité incomplète de vider totalement la vessie

Présence de globe vésical

Présence de douleur sus pubienne

Qu'est-ce qui caractérise la rétention urinaire chronique ?

Impossibilité complète d'uriner qui se traduit par un arrêt brutal et total d'uriner

Impossibilité de vider totalement la vessie

Présence de globe vésical

Existence de résidu post mictionnel

Donnez deux causes probables parmi celles qui sont énumérées en dessous ?

Activités sexuelles intenses

maladie du col vésical

phimosis serré

excès de consommation des aphrodisiaques

Quel est le signe fonctionnel qui caractérise la rétention chronique de la rétention aiguë ?

Pollakiurie diurne ou nocturne par diminution de la capacité fonctionnelle

Présence de globe vésical flaccide, parfois énorme 2 à 3 litres

Douleur sus-pelvienne

Quel est le signe physique qui caractérise la rétention chronique de la rétention aiguë ?

Pollakiurie diurne ou nocturne par diminution de la capacité fonctionnelle

Présence de globe vésical flaccide, parfois énorme 2 à 3 litres

Douleur sus-pelvienne

Quel est l'examen radiologique le plus usuel à effectuer pour confirmer le diagnostic ?

Abdomen sans préparation (ASP)

Abdomen avec préparation (AAP)

Urographie intraveineuse (UIV) avec clichés per mictionnels

En quoi consiste le traitement de M.SECONGO en urgence ?

Procéder à une intervention chirurgicale

Drainer l'urine

Quelles sont les deux méthodes préconisées pour le soulager ?

L'intervention immédiate au bloc opératoire

La laparotomie

La ponction sus-pubienne

Le sondage urétral

Quelle IEC/CCC faites-vous à M.SECONGO à sa sortie de l'hôpital ?

L'arrêt de tout rapport sexuel

La prise de toni-sexuels

Le respect du régime alimentaire

L'hygiène corporelle et surtout intime

Revenir en consultation dès la constatation d'un quelconque trouble mictionnel

Eviter les traitements traditionnels

CAS CLINIQUE N°5

IDE au centre de santé rural de Lôkaha commune de Sinématiali, vous recevez M. Sorho T. 25 ans polygame et père de 2 enfants (1 fille de 3 ans & 1 garçon de 6 mois)

L'interrogatoire, il vous signale :

Des douleurs sus pubiennes

Dysurie avec jet urinaire très fin

Miction prolongée par des gouttes retardatrices

A l'examen, vous notez :

Douleurs lombaires avec masses à la palpation

Distension vésicale

Incontinence ou miction par regorgement

Ailleurs sans particularité

Voici ses constantes :

TA= 12/7 cm Hg

T°= 37°2 C

Pouls= 60 puls/min

Quel est votre diagnostic de présomption ?

Adénome de la prostate

Rétention urinaire

Rétrécissement urétral

Quelles sont les probables causes ?

A- Activités sexuelles intenses

B- Consommation accrue d'aphrodisiaques

C-Traumatique

Quelle est votre CAT ?

Administrer des analgésiques et le référer vers le centre le plus équipé pour une meilleure prise en charge

Pratiquer une dilatation de l'urètre

Faire une coelioscopie

Demander des examens complémentaires

CAS CLINIQUE N°6

Vous recevez Mme SIKE pour douleurs abdominales et vomissements. L'interrogatoire et l'examen clinique faits par le chirurgien de service révèlent un arrêt des matières et des gaz ainsi qu'un météorisme abdominal. Celui-ci pose le diagnostic d'une occlusion intestinale aiguë haute après la lecture du cliché de l'examen radiographique demandé en urgence.

Il est indiqué chez Mme SIKE qui est âgée de 38 ans, 96 kg pour 1,55m une laparotomie; mais celle-ci institutrice de son état et directrice d'école, n'a cessé de réclamer la présence de son adjoint afin

qu'elle lui passe des consignes en vue d'une meilleure conduite des activités de l'école pendant son absence.

Donnez la définition d'une occlusion intestinale aiguë haute ?

- A- Arrêt temporaire du transit des matières et des gaz dans un segment intestinal
 - B- Arrêt incomplet et momentané du transit des matières et des gaz dans un segment intestinal
 - C-Arrêt complet et permanent du transit des matières et des gaz dans l'œsophage
 - D-Arrêt complet et permanent du transit des matières et des gaz dans l'estomac
- Arrêt complet et permanent du transit des matières et des gaz dans l'intestin grêle
- Arrêt complet et permanent du transit des matières et des gaz dans le côlon

2) Quelles sont les causes probables de cette occlusion ?

- A- les vers intestinaux
- B- la paralysie intestinale
- C-l' obésité
- D-le stress

3) Quel est l'examen le plus usuel pratiqué en urgence pour que le médecin pose le diagnostic ?

- A- la radiographie de l'abdomen sans préparation
- B- l'échographie abdominale
- C-le lavement baryté

4) Citez les mécanismes à l'origine d'une occlusion intestinale aiguë.

- A- les occlusions mécaniques
- B- les occlusions fonctionnelles
- C-le occlusions inflammatoires ou mixtes
- D-les occlusions humorales
- E-les occlusions hormonales

5) Citez sans commentaire les quatre symptômes essentiels qui caractérisent le syndrome occlusif.

- A- les douleurs abdominales
- B- les vomissements
- C-l 'arrêt des matières et des gaz
- D-le météorisme abdominal
- E-la fièvre
- F-l' hyper sialorrhée

6) Déterminez deux (2) diagnostics infirmiers dont un en rapport avec la maladie et l'autre avec la situation sociale de Mme SIKE.

- A- Douleurs abdominales dues à la pathologie
- B- Impossibilité de vaquer à son activité due à son hospitalisation
- C-Risque d'infection du site opératoire relié à l'intervention
- D-Renvoi probable dû à son inactivité

7) Identifiez et justifiez deux (2) besoins fondamentaux prioritaires à satisfaire par Mme SIKE

- A-besoin d'éliminer les déchets métaboliques
- B-besoin d'être propre, et protéger ses téguments
- C-besoin de s'occuper en vue de se rendre utile
- D-besoin de communiquer

8) Énoncez la conduite à tenir de l'infirmière à la phase préopératoire de cette affection

A- prélever du sang pour le bilan électrolytique et le groupage

B- mettre en place une perfusion

C-mettre une sonde gastroduodénale

D-mettre une sonde urinaire

E-prescrire les analgésiques

F-déléguer les soins à l'aide-soignante

CAS CLINIQUE N°7

De garde aux urgences chirurgicales, vous recevez M.Koulibali Tiorna porteur d'une plaie à l'abdomen à la suite d'une rixe à la sortie d'un bar.

Voici les constantes relevées par l'Aide-Soignante.

TA= 12/7 cm Hg

Poids= 175 kg

Pouls= 75 puls/min

T°= 37°2 C

Fréquence respiratoire= 18 cycles/min

À l'examen le médecin-chirurgien note :

Conjonctives colorées

Respiration calme et normale

Abdomen souple et dépressible

Saignement de faible abondance

Plaie linéaire outre la section cutanée n'atteint pas les tissus sous-cutanés

À l'interrogatoire, il dit avoir été agressé par un bandit.

Qu'est-ce une plaie ? (2 réponses)

La plaie est une solution sans continuité de la peau

La plaie est une solution avec continuité de la peau

La plaie est une effraction plus ou moins profonde de la peau

Quel est ce type de plaie ?

Plaie simple

Plaie complexe

Quel est l'agent agresseur probable ?

Une arme à feu

Une arme blanche

Un objet contondant

Quelle est la conduite à tenir de l'IDE dans la chronologie des actes de soins ?

A-(se laver les mains et/ou porter des gants- inspecter la plaie pour l'apprécier- la désinfecter avec un antiseptique- appliquer le produit de pansement indiqué- la recouvrir- faire le SAT)

B-(faire le SAT - se laver les mains et/ou porter des gants- inspecter la plaie pour l'apprécier- la désinfecter avec un antiseptique- appliquer le produit de pansement indiqué- la recouvrir-)

C-(inspecter la plaie pour l'apprécier- appliquer le produit de pansement indiqué- la désinfecter avec un antiseptique -la recouvrir- se laver les mains et/ou porter des gants -faire le SAT)

Quels conseils à lui donner par rapport à la plaie ?

Éviter les aliments riches en sucre

Eviter le lait écrémé

Eviter le gingembre et le curcuma

Favoriser les aliments riches en vitamine C et en protides

Eviter les souillures

Consommer beaucoup l'alcool

CAS CLINIQUE N°8

Au cours de votre garde aux urgences chirurgicales, vous recevez M. Yiého 35 ans victime d'une agression.

L'aide-soignante a noté les constantes suivantes ;

T° = 36,5°C

T.A. = 90/70 mm Hg

Poids = 85 kg

Pouls = 110 bat./min

Le médecin chirurgien relève :

Un abdomen tendu

Des douleurs abdominales diffuses

Une pâleur conjonctivale

Soif intense

Respiration superficielle

Etat général modérément altéré

Suspicion de rupture de la rate

Le médecin prescrit :

Une transfusion de sang total :

- 1façon de 450 cm³ en 3H et demie

- Ceftriaxone 1g ampoules inj.: 1amp.x 2/jour en IVD

- Trabar inj. : 1amp.x 3/jour en IM (1amp.= 5 ml)

Quel est l'examen à faire pour confirmer la rupture de la rate ?

La radiographie de l'Abdomen Avec Préparation

La radiographie de l'Abdomen Sans Préparation

La Numération Formule sanguine

La Vitesse de Sédimentation

Dans quel cadran de l'abdomen est située la rate ?

l'hypochondre gauche

l'hypochondre droit

le flanc gauche

le flanc droit

quels sont les rôles de la rate ? (3 réponses)

participation au système immunitaire

réservoir de sang

destruction des globules rouges vieillissants

participation à l'accroissement des organes intraabdominaux

Elaboration des hormones

Synthèse des protéines

Quel peut-être l'agent causal de cette contusion ? (1 réponse)

La machette

Le bâton

Le pistolet

Quel type de contusion est en cause ?

une contusion simple

une contusion grave

Quels les éléments en faveur de cette contusion en cause ?

Des douleurs abdominales diffuses

Une pâleur conjonctivale

Etat général modérément altéré

T.A. à 90/70 mm Hg

Poids à 85 kg

Température à 36°5 C

Quelle est la température normale chez un individu sain ?

30° à 36°C

36°5 à 42°C

36°5 à 37°5 C

37°5 à 38°5 C

Quels sont les signes en faveur du choc hémodynamique ? (2 réponses)

La coloration des téguments

Les douleurs abdominales diffuses

Le pouls filant

La pression artérielle basse

Trois des signes ci-dessous sont évocateurs d'une hémorragie interne. Lesquels ?

douleurs diffuses

Abdomen tendu

Extrémités insensibles

Soif intense

respiration superficielle

Langue saburrale

Quelle est la principale conséquence de l'ablation de la rate ?

Expose l'organisme à des infections plus fréquentes

Aggrave l'anémie

Arrête l'accroissement des organes intra-abdominaux

Régularise la production des hormones

Quel sera le débit de la transfusion ?

30 gouttes/min

32 gouttes/min

33 gouttes/min

34 gouttes/min

Quelles sont les interventions infirmières dans la prise en charge de M.Yiého ?

Se présenter au patient

Prendre régulièrement les constantes hémodynamiques

Administrar la médication prescrite

Déléguer les soins à l'auxiliaire

Surveiller la déglutition

Surveiller le faciès

CAS CLINIQUE N°9

IDE au centre de santé rural de NAKALAH S/P de KOGAHA, vous recevez M. TUO Zolwa grand cultivateur de coton et planteur d'anacarde dans le village. Marié à 3 femmes et père de 9 enfants.

Il lui a été détecté un diabète de type I depuis 6 mois

L'Aide-Soignante vous donne ses constantes :

Poids= 105 kg

Taille= 1m74

TA= 14/8 cm Hg

Age= 52 ans

T°= 37°5 C

Pouls= 76 bat./min

FR= 20 c/min

A l'interrogatoire, il vous signale ;

Une douleur spontanée et vive au niveau de l'abdomen

Des vomissements précédés de nausées

A l'examen, vous notez :

Une tuméfaction luisante dans le cadran droit de l'abdomen, tendue, douloureuse, non impulsive et non expansive à la toux

Quel est votre diagnostic ?

Appendicite aiguë

Hernie non compliquée

Hernie étranglée

Quels sont les signes qui justifient le diagnostic ?

Douleur spontanée et vive à l'abdomen

Tuméfaction luisante non impulsive et non expansive à la toux

Fébricule

Nausées

Vomissements

Quelles sont les causes probables de cette pathologie ?

Obésité

Diabète

Travaux de force

Activités sexuelles intenses

Age

Quelle est votre CAT au centre de santé ?

(mise en observation + antibiotique + antalgique)

(voie veineuse + antibiothérapie + anti-inflammatoire)

(voie veineuse + antalgique + antibiothérapie + anti-inflammatoire)

(voie veineuse si possible + antalgique + évacuation)

CAS CLINIQUE N°10

Pendant la permanence aux urgences du CHU de Bouaké, vous recevez Mme Diomandé 45 ans adressée par une infirmerie privée de la place pour :

Douleurs abdominales diffuses en << coup de poignard >>

Nausées et vomissements

TA à 90/50 mm Hg

Pouls à 110 battements par minute

Fièvre à 39°5 C

Elle présente par ailleurs une anémie et un amaigrissement modéré

Après un examen clinique minutieux, le chirurgien décide de l'opérer dans deux (02) jours.

On lui fait les prescriptions suivantes :

La correction de l'anémie par transfusion sanguine

Une réanimation hydroélectrolytique

Une antibiothérapie

Une aspiration digestive

A quelle affection vous font penser ces signes ?

Ulcère gastro-duodéal

Pancréatite aigüe

Grossesse tubaire

Péritonite aigüe

Occlusion intestinale aigüe

Choisir deux (02) causes probables parmi celles-ci

Traumatisme fermé de l'abdomen

Ulcère gastroduodéal perforé

Hernie hiatale

Salpingite

Quel est le signe fondamental que recherche l'examen physique ?

La paresthésie cutanée

La douleur abdominale constante

L'hyperthermie

La contracture abdominale ou "ventre de bois"

L'anémie

L'hyperleucocytose

Cochez les bonnes réponses

Quels sont les soins que vous lui donniez avant l'arrivée du chirurgien ?

Administration d'antipyrétique

Administration d'antiémétique

Accueil et installation du malade

Prise des constantes

Lui présenter un haricot en cas de vomissement

Lui dire son diagnostic

Cochez les bonnes réponses

Quelles sont les précautions à prendre avant la pose de la poche de sang ?

Faire le test de compatibilité

Vérifier la concordance de la poche de sang avec le sang prescrit

Voir l'aspect du sang

Bien régler le débit de la transfusion

Vérifier l'écoulement du sang

S'assurer si le malade n'a pas de besoin urgent

Lors de la pose de cette transfusion, vous vous êtes piqué(e) avec l'aiguille non souillée par le sang.

Cochez les bonnes réponses

Que faites-vous ?

Faire saigner la plaie

Nettoyer la plaie avec une solution antiseptique et continuer le soin

Informez le Major et Arrêtez le soin entrepris

Faire le test de VIH

Demander à l'Aide-Soignant de vous suppléer et vous rentrez chez vous

Ne pas faire une déclaration d'AES chez le médecin référent

Cochez les bonnes réponses

Quels sont les éléments de surveillance de l'aspiration digestive ?

Surveiller les constantes

Apport liquidien oral pour compenser les pertes liquidiennes

Surveiller l'aspect et la quantité du liquide aspiré

Mobiliser la sonde pour qu'elle n'adhère pas à la paroi gastrique

Contrôler le bon fonctionnement de l'appareillage

Vérifier l'état général du patient

Cochez les bonnes réponses

Quels sont les éléments de préparation physique la veille de l'intervention ?

Contrôler les constantes hémodynamiques

Faire un rasage de l'abdomen et du pubis

Désinfecter la peau au moyen de solution antiseptique et recouvrir la partie avec un champ opératoire stérile

Contrôler le réveil physiologique du malade

S'assurer que le patient est à jeun la veille de l'intervention

Prescrire la prémédication

Choisir la bonne réponse

Quel est le besoin prioritaire non satisfait ?

Besoin de maintenir la température du corps dans les limites normales

Besoin de respirer

Besoin de s'occuper de façon à se sentir utile

Besoin de communiquer avec ses semblables

Besoin de manger et boire

Besoin de se mouvoir et se maintenir dans une position convenable

Mme DIOMANDE est transfusée avec 980cc de sang total.

Quelles sont les méthodes qui permettront de déterminer son groupe sanguin et rhésus ?

Méthode de BED VINCENT

Méthode de SIMON

Méthode de BETH SIMONIN

Méthode de BETH SIMONNE

Méthode de BETH VINCENT

Méthode de SIMONIN

Sachant que les sérums tests AntiA, AntiB, AntiAB n'agglutinent pas son sang sauf l'antiD. Quel est le groupe sanguin de Mme DIOMANDE ?

O négatif

AB négatif

O positif

AB positif

Calculez le nombre de poches de sang nécessaire sachant que le CNTS ne dispose que des poches de 500 ml.

2 poches

3 poches

4 poches

Déterminez le débit d'une poche de sang devant passer en 2heures et quart ?

108 gouttes/min

109 gouttes/min

55 gouttes/min

56 gouttes/min

62 gouttes/min

72 gouttes/min

CAS CLINIQUE N°11

Un adolescent de 17 ans, LAURENT fait une chute de cyclomoteur en se rendant au Lycée. Il est amené par le SAMU aux urgences de l'hôpital le 13/12/21 à 8 heures 30 minutes.

Il est choqué et respire difficilement mais conscient, présentant de nombreuses excoriations cutanées avec un traumatisme important sur le côté gauche. Le médecin après examen clinique pose le diagnostic de fracture fermée du fémur. Aussi, celui-ci suspecte une rupture de la rate.

L'aide-soignante a noté les constantes suivantes :

Poids= 50 kg

TA= 9/7 cm Hg

FR= 18 c/ min

T° = 36°5 C

< Ò "R VÇ2ò Ö-à

Le médecin prévoit une intervention chirurgicale ce jour plutôt à 18 heures.

Le taux d'hémoglobine à son arrivée est à 5g/dl

Le traitement suivant a été prescrit en attendant.

Sang iso groupe iso rhésus : 2 flacons de 400 cc en 3 heures chacun

Sérum glucosé : 1 litre en 12 heures

Chlorure de sodium (NaCl) : 10 ml/litre

Chlorure de potassium (KCl) : 10 ml/litre

Ceftriaxone 1g : 1g en IVD à 12h et 16h

Pose d'une sonde urinaire

Ponction lavage péritoine

A quel squelette appartient le fémur ?

Squelette axial

Squelette appendiculaire

Squelette zonal

Dans quel cadran de l'abdomen est située la rate ?

L'épigastre

L'hypochondre gauche

Le flanc gauche

La fosse iliaque gauche

La région ombilicale

L'hypogastre

Définir la fracture fermée du fémur

Rupture de la continuité de l'os situé dans le bras

Rupture de la continuité de l'os situé dans la cuisse dont le foyer de fracture ne communique pas avec l'extérieur par une plaie

Rupture de la continuité de l'os situé dans la cuisse dont le foyer de fracture communique l'extérieur par une plaie minime

Rupture de la continuité de l'os situé dans le bras

Qu'est-ce qu'une fracture pathologique ?

Fracture survenant à la suite d'un traumatisme important

Fracture survenant à la suite d'un traumatisme minime

Quels sont les signes de choc dans le texte ?

Tension artérielle basse

Pouls filant

Sueurs profuses

Agitation

Dyspnée

Soif intense

Quel est ce type de choc ?

Choc cardiogénique

Choc hypovolémique

Choc anaphylactique

Choc septique

Identifiez trois fonctions de la rate parmi celles qui sont énumérées en dessous ?

Réservoir de sang

Participe à la destruction des globules sanguins vieillis

Participe à la formation des os

Produit des hormones

Purifie le sang

Quels sont les rôles des os ?

constituent la charpente du corps

permettent les mouvements

forment un système protecteur

constituent une réserve de graisse et de sels minéraux

participent à l'hématopoïèse

couvrent tous les organes mous

Identifiez les signes cliniques de la fracture parmi les signes énumérés ci-dessous ?

Douleur à la mobilisation du membre atteint

Impotence fonctionnelle

Déformation du membre atteint

Hyperthermie

Sénilité

Asthénie

Quel est le but de la prescription de sang ?

Rétablir la volémie

Nourrir le blessé

Réhydrater le blessé

Permet de poser le diagnostic

Réparer la rupture suspectée de la rate

Prévenir l'infection

Quel est le but de la pose urinaire ?

Réhydrater la victime

Laver la vessie de la victime

Prévenir l'infection urinaire due aux nombreuses excoriations

Quantifier la diurèse

Renforcer son système urinaire

Quel est le débit d'une poche de sang ?

32 gttes/min

33 gttes/min

34 gttes/min

Quel est le débit de la perfusion du flacon de glucosé ?

55 gttes/min

56 gttes/min

57 gttes/min

Quel est son groupe sanguin sachant que selon la méthode de Beth Vincent les sérums tests ; $\hat{A}^2$; 32 et antiD agglutinent son sang ?

AB positif

O positif

AB négatif

O négatif

A positif

B positif

Aussi, désire-t-on ramener son taux d'hémoglobine à 10 g/dl avec du sang total. Quelle est la formule à appliquer ?

$Q \text{ Sang} = 2\text{ml} \times \text{Poids (kg)} \times \text{TxHb}$

$Q \text{ Sang} = 1\text{ml} \times \text{poids (kg)} \times \text{Tx Hb}$

$Q \text{ Sang} = [\text{Tx Hb à atteindre} - \text{Tx Hb mesurée}] \times 6 \times \text{poids (kg)}$

$Q \text{ Sang} = [\text{Tx Hb à atteindre} - \text{Tx Hb mesurée}] \times 4 \times \text{poids (kg)}$

$Q \text{ Sang} = 4\text{ml} \times \text{poids (kg)} + \text{Tx Hb}$

Formulez sous forme de diagnostic infirmier deux problèmes prioritaires de Laurent en rapport avec sa Fracture

Douleur liée à la fracture du fémur

Impotence fonctionnelle du membre reliée à la fracture

Risque de septicémie dû à la fracture

Trouble du sommeil dû à la fracture

Formulez sous forme de diagnostic infirmier deux problèmes prioritaires de Laurent en rapport avec la rupture de la rate

Risque d'infection relié à la rupture de la rate

Anémie probable reliée à la rupture de la rate

Impossibilité de pratiquer sa religion due à son traumatisme

Risque d'ablation de la rate dû à la rupture de la rate

Quel est le besoin fondamental à satisfaire chez Laurent face ce traumatisme ?

Besoin de se recréer

Besoin de manger et boire

Besoin de vaquer à ses occupations

Besoin de dormir et se reposer

Besoin d'éviter le danger

Besoin de se mouvoir

CAS CLINIQUE N°12

Venu consulter au centre de santé rural de Kogaha, vous remarquez chez M.Sanoko A. les symptômes suivants :

A l'inspection

Sensation de pesanteur à la marche

De grosses bourses indolentes

Peau du scrotum dépliée

Existence de signes d'inflammation

Disparition de la verge dans un repli cutané

A la palpation

Tuméfaction rénitente fluctuante

Matité à la sonorité

Impossibilité de pincer la vaginale

Tuméfaction transparente à la transi-lumination (épreuve de la lampe)

Irréductible

Non expansive à la toux

Quel est votre diagnostic ?

Hernie scrotale étranglée

Adénome de la prostate

Rétention urinaire

Cryptorchidie

Hermaphrodite

Hydrocèle

Donnez trois (03) signes à l'inspection permettant de confirmer le diagnostic

Sensation de pesanteur à la marche

De grosses bourses indolentes

Peau du scrotum dépliée

Existence de signes d'inflammation

Disparition de la verge dans un repli cutané

Donnez deux (02) signes à la palpation permettant de confirmer le diagnostic

Tuméfaction rénitente fluctuante

Matité à la sonorité

Impossibilité de pincer la vaginale

Tuméfaction transparente à la transi-lumination (épreuve de la lampe)

Irréductible

Non expansive à la toux

Quel est l'examen complémentaire à pratiquer ?

Abdomen sans préparation

Abdomen avec préparation

Echographie

Tomodensitométrie

Imagerie par résonance magnétique

Quelle est votre conduite à tenir au centre ?

Mise en observation + perfusion

ponction à l'aiguille + pansement

soins spécifiques + référé

SUJETS D'EXAMENS

Sujet 1

IDE au CSR d'ANGOUA-YAOKRO dans le district sanitaire de Bouaké, vous êtes sollicités pour porter secours à M.Ousmane, polytraumatisé de la voie publique.

Votre examen général fait sur le lieu de l'accident révèle :

Fracture ouverte des 2 os de la jambe gauche ;

Fracture fermée du fémur droit

Luxation antéro-interne sous coracoïdienne de l'épaule gauche

TA= 80/50 mm Hg

" = 110 bat/min

T°= 36°5 C

Les extrémités sont froides

Il est conscient mais très anxieux. Il demande qu'on l'évacue au CHU de Bouaké.

Que faites-vous avant son évacuation ? Choisissez la bonne réponse

Préparation psychologique

Immobilisation provisoire des membres fracturés

Réduction des membres fracturés

Pose de perfusions

Pose de sonde naso-gastrique et urinaire

Administration de produits médicamenteux

Parmi les signes suivants, choisir 2 signes fonctionnels liés aux fractures d'Ousmane

Hyperthermie

Douleur intense

Impotence fonctionnelle

Déformation des membres fracturés

Œdème au niveau de la clavicule

Recherche des complications

L'IDE a noté une absence de pouls tibiaux et pédieux. Choisir la bonne réponse

Il y a lésion vasculaire

Il n'y a pas de lésion vasculaire

Comment l'IDE peut-il rechercher la sensibilité et la motricité au niveau du pied ? Choisir la bonne réponse

En mobilisant le membre

En piquant le pied avec un objet piquant

En faisant effectuer un geste simple du pied par Ousmane

En mettant le pied en contact avec une source d'énergie thermique

Quelles sont les complications immédiates auxquelles est exposé M. Ousmane face à la luxation de son épaule ? Choisir les 2 bonnes réponses

Compression vasculaire

Compression ou élongation nerveuse

Cals vicieux

Pseudarthroses

Au vu des constantes hémodynamiques, quel est le type de choc qu'Ousmane pourrait faire ?

Choc anaphylactique

Choc cardiogénique

Choc hypovolémique

Choc septique

Sujet 2

A/ QCM

Bonne réponse = 1 point ; Mauvaise réponse ou pas de réponse = Zéro point

Choisir les 3 bonnes réponses

Le rôle de l'infirmier(e) avant la transfusion est de :

Vérifier l'identification du destinataire et/ou du producteur

Vérifier la date de prélèvement et de péremption des produits sanguins

Contrôler les constantes hémodynamiques

Faire le test d'incompatibilité

Rechercher des signes d'anomalie

Rechercher les accidents d'exposition au sang

Les contre-indications de la perfusion sont : choisir 4 réponses

Alimentation parentérale

Anémie sévère

Intervention chirurgicale

Œdème aigu des poumons

Anasarque

Insuffisance cardiaque

Les signes cliniques d'une luxation traumatique sont : choisissez les 3 bonnes réponses

douleur de l'articulation

déformation de l'articulation

modification de la longueur du membre

hyperthermie

Les luxations peuvent être : choisissez la bonne réponse

A- Congénitales

Spontanées

Pathologiques

Traumatiques

Congénitales ; spontanées/pathologiques ; traumatiques

L'infection des gaines de l'appareil digital de la main par germes pathogènes est dénommée : cochez la bonne réponse

Gangrène

Panaris

Anthrax

Phlegmon

Les différentes phases successives du phénomène de l'inflammation sont : choisir la bonne réponse

La phase cellulaire-la phase vasculaire-la phase de réparation

La phase vasculaire-la phase cellulaire-la phase de réparation

La phase de réparation-la phase vasculaire-la phase cellulaire

le traitement d'une luxation récente consiste à : choisir les 2 bonnes réponses

traitement orthopédique seulement

traitement sanglant seulement

référer le blessé chez un chirurgien en cas d'échec

rechercher des complications associées et s'abstenir de toute intervention

Les raisons de l'éventuel échec à la réduction de la luxation de l'épaule sont : choisir les 3 bonnes réponses

le blessé a été vu tardivement

le blessé est trop maigre

le blessé est trop musclé

le blessé a des signes évidents de complications

Les interventions infirmières dans la luxation consistent à : choisir les 2 bonnes réponses

dépister les complications neurovasculaires

soutenir psychologiquement le patient

assurer les soins de nursing

suivre uniquement les décisions du chirurgien

Quels sont les deux (02) signes cliniques qui relèvent de l'abcès froid, parmi ceux proposés ci-dessous ?

Céphalées b- Prostration C- Gonflement local mou d- Douleur e- Modification locale de la couleur de la peau f- hyperthermie

Parmi les signes indiqués ci-dessous, deux (02) relèvent des signes fonctionnels de l'hémorragie interne. Lesquels ?

Acidose respiratoire b-Taux d'hémoglobine inférieur à 4 g/dl

c-Extrémités froides d-Pouls petit et filant

B/QCD

Bonne réponse = 1 point ; Mauvaise réponse = - 1 point Pas de réponse = Zéro point

Entourez A= Vrai ou B= Faux pour les affirmations ci-dessous

On appelle fracture, la rupture de la continuité du tissu musculaire A/B

La survenue d'une fracture se fait toujours par un choc direct A / B

Le syndrome de Wolkman survient uniquement avec la pose d'un appareil plâtré A/ B

Un poly-fracturé est un polytraumatisé A / B

L'antisepsie en chirurgie désigne l'ensemble des méthodes qui préserve contre la souillure des microbes tout ce qui est en contact avec la plaie opératoire A/B

L'articulation de l'épaule est dite amphiarthrose A/B

Au cours d'une luxation traumatique, une fracture associée peut être décelée par l'échographie de l'articulation A/B

Toute infection avec décharges importantes et répétées de germes dans le sang à partir d'un foyer septique détermine une septicémie A/B

Tous les germes sont pathogènes A/B

La notion de terrain en sémiologie signifie le lieu de travail du sujet A/B

Le sérum glucosé 5% est un soluté de remplissage A/B

Dans les prodromes de l'appendicite aiguë, la diarrhée est plus fréquente que la constipation A/B

L'occlusion intestinale relève de trois (03) processus A/B

La pollakiurie signifie la diminution de la force et du calibre du jet urinaire A/B

Un patient du groupe sanguin A rhésus positif peut recevoir du sang du groupe O négatif A/B

CAS CLINIQUE N°1

L'élève HILI S. 20 ans, fait une chute de cyclomoteur en se rendant au Lycée. Il est amené par le SAMU aux urgences de l'hôpital.

Il est choqué et respire difficilement mais conscient. Le médecin après examen clinique pose le diagnostic de fracture fermée du fémur.

A quel squelette appartient le fémur ?

Squelette axial

Squelette appendiculaire

Squelette zonal

Dans quel cadran de l'abdomen est située la rate ?

L'épigastre

L'hypochondre gauche

Le flanc gauche

La fosse iliaque gauche

La région ombilicale

L'hypogastre

Définir la fracture fermée du fémur

Rupture de la continuité de l'os situé dans le bras

Rupture de la continuité de l'os situé dans la cuisse dont le foyer de fracture ne communique pas avec l'extérieur par une plaie

Rupture de la continuité de l'os situé dans la cuisse dont le foyer de fracture communique avec l'extérieur par une plaie minime

Qu'est-ce qu'une fracture pathologique ?

Fracture survenant à la suite d'un traumatisme important

Fracture survenant à la suite d'un traumatisme minime

Identifiez les signes cliniques de la fracture parmi les signes énumérés ci-dessous ?

Douleur à la mobilisation du membre atteint

Impotence fonctionnelle

Déformation du membre atteint

Hyperthermie

Sénilité

Asthénie

CAS CLINIQUE N°2

Mlle Sulié T. 20 ans, étudiante en Licence3 communication à la FLASH de l'Université A.O de Bouaké est amenée aux urgences chirurgicales pour douleurs abdominales brutales dans la fosse iliaque droite, avec nausées, vomissements et hyperthermie. Ces conjonctives sont colorées. La pression artérielle est normale.

QUESTIONS

De quoi souffre Mlle Sulié T. ?

Ulcère gastroduodénal

Occlusion intestinale aiguë

Appendicite aiguë

Péritonite généralisée

Quels sont les éléments qui vous permettent de poser ce diagnostic ? (choisir 3 éléments)

Douleurs dans la fosse iliaque droite

Nausées et vomissements

Tension artérielle normale

hyperthermie

Conjonctives colorées

Quels sont les examens à faire pour confirmer le diagnostic ? (choisir 2 examens)

KOP

ECBU

Echographie abdominale

NFS/VS

Quels peuvent être les autres diagnostics différentiels ? (choisir 2 éléments)

Salpingite droite

Torsion de kyste

Colique néphrétique

Constipation opiniâtre

Quelles sont les probables causes de la pathologie de Mlle Sulié T. ? (choisir 2 réponses)

Parasitoses intestinales

Coprolithes

Obésité

Stress